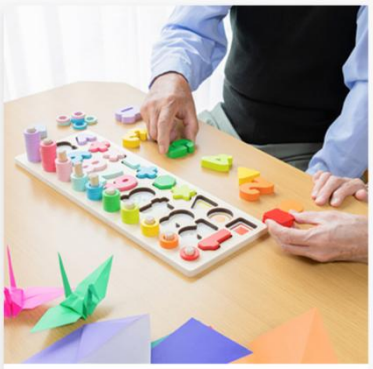




第十四届“今经乐道”经济热点分析大赛

养老不离家，福寿映晚霞

——居家养老照护行业的多维透视



长生不老队

魏雪懿 | 黄静远 | 杜佳林 | 张书嘉

目录

目录 2
图表目录 4
研究思路 6
研究摘要 7
1. 背景综述 8
1.1. 人口老龄化的现状与趋势 8
1.1.1. 老年人口多 8
1.1.2. 老龄化进程快 10
1.1.3. 高龄化严重 11
1.2. 人口老龄化带动“银发经济”发展 11
1.2.1. 需求理论视角 12
1.2.2. 行业关系视角 13
2. 养老照护服务行业 15
2.1. 养老照护服务行业宏观环境分析 15
2.1.1. 政治环境（Political） 15
2.1.2. 经济环境（Economic） 17
2.1.3. 社会环境（Social） 21
2.1.4. 技术环境（Technological） 21
2.2. 养老照护服务行业市场情况 21
3. 居家养老照护行业 23
3.1. 居家模式将成为未来养老照护行业主流 23
3.2. 居家养老照护行业的特点 25
3.2.1. 行业发展处于早期阶段 25
3.2.2. 老人需求未被充分满足 26
3.2.3. 和保险结合紧密 28
3.3. 中日对比，一窥未来商业模式 32
3.3.1. 运营模式 32
3.3.2. 长护险制度 33
4. 微观分析 34
4.1. 福寿康发展现状分析 35
4.1.1. 福寿康简介 35
4.1.2. 福寿康业务开展情况 36
4.1.3. 主要企业对比分析 38

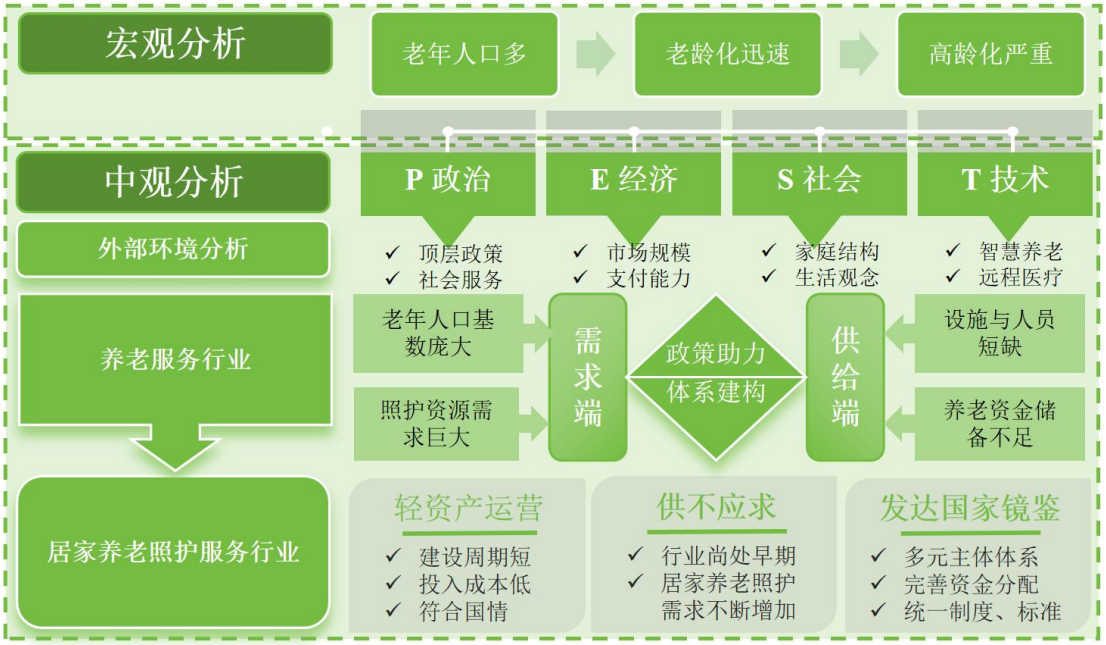
4.1.4. 福寿康 SWOT 分析 39
4.2. 美国居家照护服务个案研究 44
4.2.1. Amedisys 公司简介 45
4.2.2. Amedysis 公司业务 45
4.2.3. Amedysis 公司商业模式 45
4.3. 福寿康发展战略 47
4.3.1. 要素投入：人才优化与技术迭代双措并举 48
4.3.2. 短期战略：内生增长，快速规模化 49
4.3.3. 长期战略：外延并购，业务多元化 49
4.3.4. 盈利实现：持续商业化 50
4.3.5. 目标达成：打通养老服务全链条 51
5. 总结与展望 51
5.1. 行业端：产业发展与政策保障协同，共同打造老年友好型社会 51
5.2. 企业端：展望未来十年，助天下长者生活更美好 52
5.2.1. 2024—2027 年：夯实基础，推动业务规模化 53
5.2.2. 2028—2030 年：整合并购，赋能服务多元化 53
5.2.3. 2031—2035 年：打通养老服务全链条，实现一体化智慧养老 54
参考文献 55

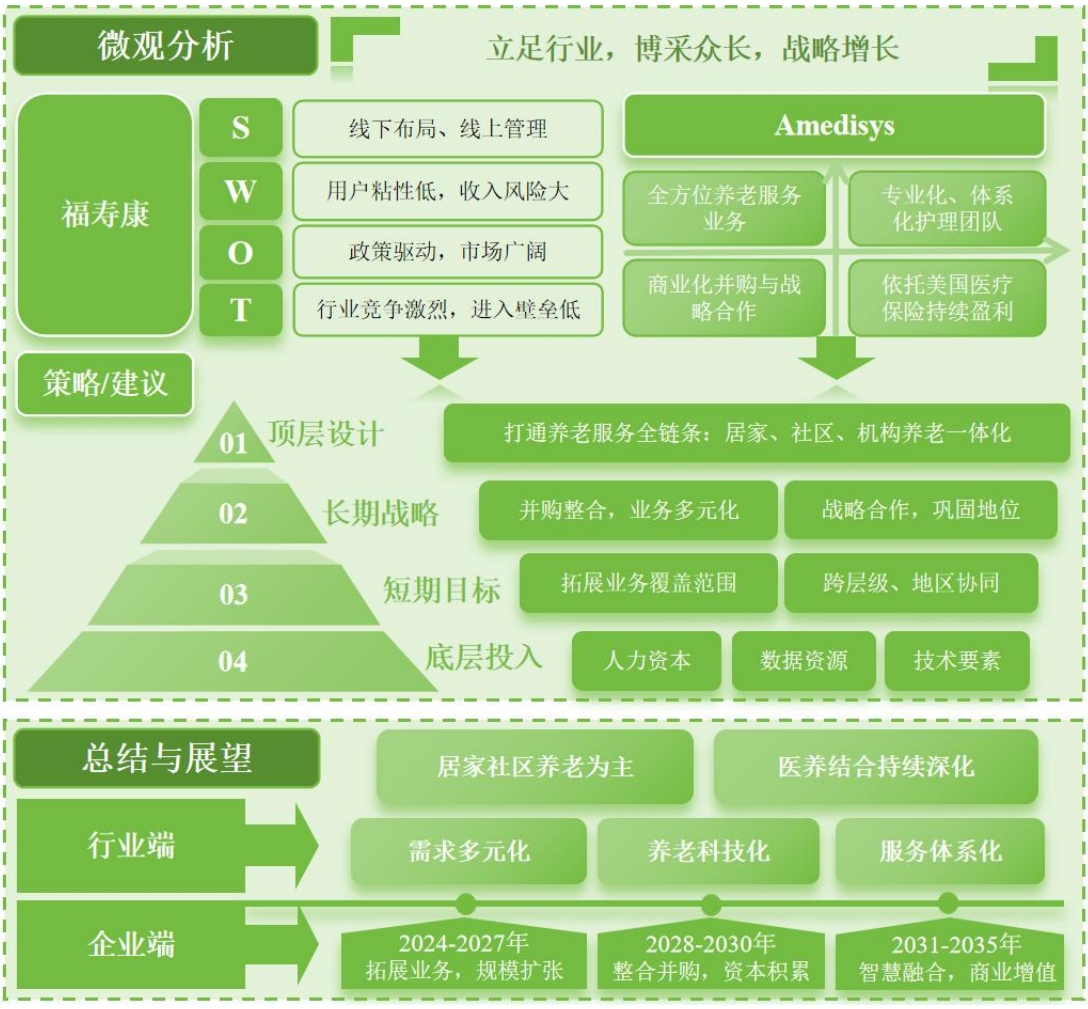
图表目录

图表 1 ：2013 年—2023 年全国 60 周岁及以上老年人口数量及占全国总人口比重 9
图表 2 ：2013 年—2023 年全国 65 周岁及以上老年人口数量及占全国总人口比重 9
图表 3 ：2013 年—2023 年全国 65 周岁及以上老年人口抚养比 9
图表 4 ：未来 60 岁、80 岁及以上人口年平均增长速度预测 11
图表 5 ：中国银发经济市场产业图谱一览 12
图表 6 ：养老产业链 13
图表 7 ：政策文件中所包括的银发经济关键词分类网络关系图 14
图表 8 ：中国银发经济产业链 15
图表 10 ：2019 年以来国家层面重要政策解读 16
图表 11 ：2020—2026 年中国银发经济市场规模趋势预测 18
图表 12 ：2020 年各国养老金规模 19
图表 13 ：我国城镇居民基本养老金替代率历年变化 19
图表 14 ：我国现行养老制度体系 20
图表 15 ：各国养老三大支柱体系图示 20
图表 16 ：2016—2021 年养老有效需求与床位供给情况 22
图表 17 ：2023 年老年人护理床位缺口 23
图表 18 ：2023 年养老护理人员缺口 23
图表 19 ：2018—2023 年我国养老机构空床率 24
图表 20 ：2021 年整体市场养老机构盈亏状况 24
图表 21 ：机构养老和居家养老商业模式对比 24
图表 22 ：我国居家养老的三种主要模式 25
图表 23 ：国内头部居家养老服务提供商基本情况介绍 25
图表 24 ：居家养老主要服务需求 27
图表 25 ：购买使用过的居家养老服务 27
图表 26 ：不同地区购买使用过居家养老服务 27

图表 27 ：居家养老服务质量满意度水平 28
图表 28 ：居家养老服务收费合理性评价 28
图表 29 ：15 个试点城市长期护理保险支付待遇对比 29
图表 30 ：我国在售商业护理保险产品概览 32
图表 31 ：2018—2022 年我国商业护理保险保费情况 32
图表 32 ：日本介护保险制度保费构成 33
图表 33 ：我国长护险享受待遇人数较低（2020—2023） 34
图表 34 ：中日长护险使用率对比（2020—2023） 34
图表 35 ：福寿康发展历程 35
图表 36 ：福寿康年服务量持续增长 35
图表 37 ：福寿康“医护康养”生态圈 36
图表 38 ：福寿康“照护 365”小程序界面 37
图表 39 ：代表性企业发展情况对比 38
图表 40 ：福寿康 SWOT 分析图示 40
图表 41 ：福寿康全国布局图 41
图表 42 ：颐家养老全国布局图 41
图表 43 ：璞缘照护全国布局图 41
图表 44 ：小橙集团全国布局图 41
图表 45 ：福寿康发展战略示意图 47

研究思路


宏观分析
老年人口多
老龄化迅速
高龄化严重
中观分析
外部环境分析
养老服务行业
居家养老照护服务行业
P 政治
E 经济
S 社会
T 技术
✓ 顶层政策
✓ 社会服务
✓ 市场规模
✓ 支付能力
✓ 家庭结构
✓ 生活观念
✓ 智慧养老
✓ 远程医疗
老年人口基数庞大
照护资源需求巨大
需求端
政策助力
体系建构
供给端
设施与人员短缺
养老资金储备不足
轻资产运营
✓ 建设周期短
✓ 投入成本低
✓ 符合国情
供不应求
✓ 行业尚处早期
✓ 居家养老照护需求不断增加
发达国家镜鉴
✓ 多元主体体系
✓ 完善资金分配
✓ 统一制度、标准


微观分析
立足行业，博采众长，战略增长
福寿康
S
W
O
T
线下布局、线上管理
用户粘性低，收入风险大
政策驱动，市场广阔
行业竞争激烈，进入壁垒低
Amedisys
全方位养老服务业务
专业化、体系化护理团队
商业化并购与战略合作
依托美国医疗保险持续盈利
策略/建议
01 顶层设计
打通养老服务全链条：居家、社区、机构养老一体化
02 长期战略
并购整合，业务多元化
战略合作，巩固地位
03 短期目标
拓展业务覆盖范围
跨层级、地区协同
04 底层投入
人力资本
数据资源
技术要素

总结与展望
行业端
企业端
居家社区养老为主
医养结合持续深化
需求多元化
养老科技化
服务体系化
2024-2027年
拓展业务，规模扩张
2028-2030年
整合并购，资本积累
2031-2035年
智慧融合，商业增值

研究摘要

2021 年 12 月 30 日，国务院印发《“十四五”老龄事业发展和养老服务体系规划》，明确提出发展多层次、多样化的养老服务体系，要加快建设居家、社区、机构相协调，医养康养相结合的养老服务体系和健康支撑体系。本报告采取自上而下的视角，从多个维度分析了中国居家养老照护行业发展的现状、动力和不足，并结合具体的企业案例，描绘行业发展图景，预测行业趋势。

在宏观层面，我们分析了中国老龄化的背景，指出中国老龄化人口多、进程快、高龄化严重的特点。人口老龄化带动银发经济发展，我们分别从需求理论和行业关系的视角，分析银发经济产业链。

在中观层面，我们聚焦于养老照护行业。首先，我们运用 PEST 方法，分析了养老照护行业面临的外部环境。其次，我们分别从供给侧和需求侧，分析了当前养老照护行业的市场状况。此外，我们通过对比三种不同的养老照护方式的运营模式，结合目前中国养老格局，得出居家养老将成为我国未来养老照护行业主流的结论。基于此，我们进一步具体分析了居家养老行业目前的行业特点。最后，我们通过对比中日居家养老的运营模式和长护险制度，明晰了中国居家养老行业当下的不足和未来的改善方向。

在微观层面，我们采取案例分析的方法，选取中国居家养老行业的龙头公司福寿康，运用 SWOT 方法分析其业务布局、商业模式、竞争优势、不足与困境，从微观层面展现了前文所述商业模式和运营机制的实际落地。在此基础上，我们以美国居家养老龙头公司 Amedisys 的发展经验为鉴，从底层投入、短期战略、长期战略、顶层设计四个方面为福寿康提出了未来进一步的发展路径。

最后，我们基于以上所有分析，总结出了我国养老产业发展的五大趋势；并展望了未来十年，居家养老企业从拓展业务、到整合并购、再到智慧化运营的三个发展阶段。未来，希望我国养老产业能蓬勃发展，助天下长者生活更美好。

关键词：银发经济，养老照护，居家养老，福寿康

1. 背景综述

1.1. 人口老龄化的现状与趋势

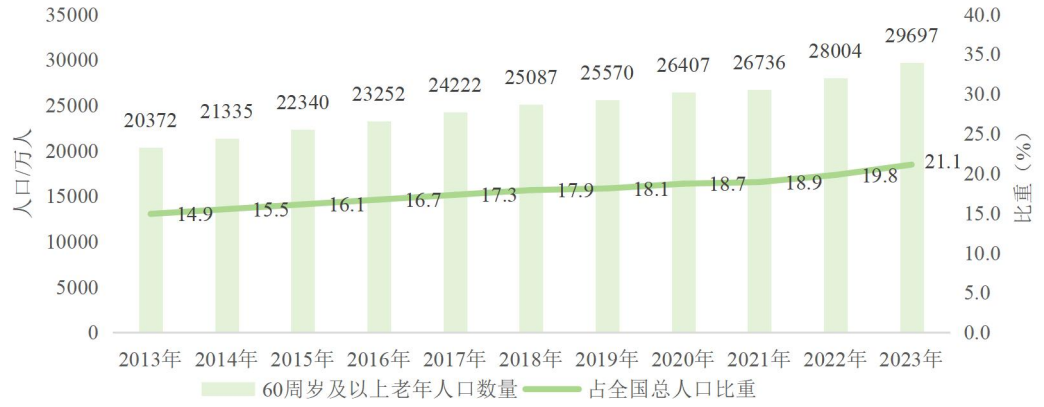
人口结构的演变长期而复杂，不仅影响着社会的养老负担程度和劳动力供给情况，还关系到经济的增长模式和消费模式。20 世纪中叶以来，中国的人口结构经历了显著变化。1990 年前后，中国的人口结构呈现典型的扩张型，即年轻人口占据主导地位，生育率较高、人口增长较为迅速。随着计划生育政策的严格执行，中国的新生儿数量开始明显减少，这导致了人口结构开始向收缩型转变，老年人口比例逐渐上升。进入 21 世纪，中国的人口结构中老年型特征更加明显，劳动力市场面临挑战。2020 年前后尽管出生人口有所回升，但人口结构已转变为典型的收缩型，30 至 60 岁年龄段人口成为主流。这一变化标志着中国社会开始步入老龄化阶段，对养老、医疗、社会保障等领域提出了新的挑战。2022 年、2023 年，中国人口总量连续两年出现负增长，标志着中国进入了所谓的“双收缩社会”。预示着未来中国将面临人口数量和结构的双重挑战。虽然随着生育等政策的调整，未来人口结构有望出现新的变化与转机，但由于人口变化的惯性，人口出生率低于更替水平，全国人口绝对数量持续下降的趋势似乎不可避免。

人口老龄化是全球普遍现象，但中国的情况具有独特性，主要表现为规模大、速度快、高龄化、未富先老、养老负担加重。其中，**老年人口多、老龄化进程快、高龄化**是最为显著的特征。

1.1.1. 老年人口多

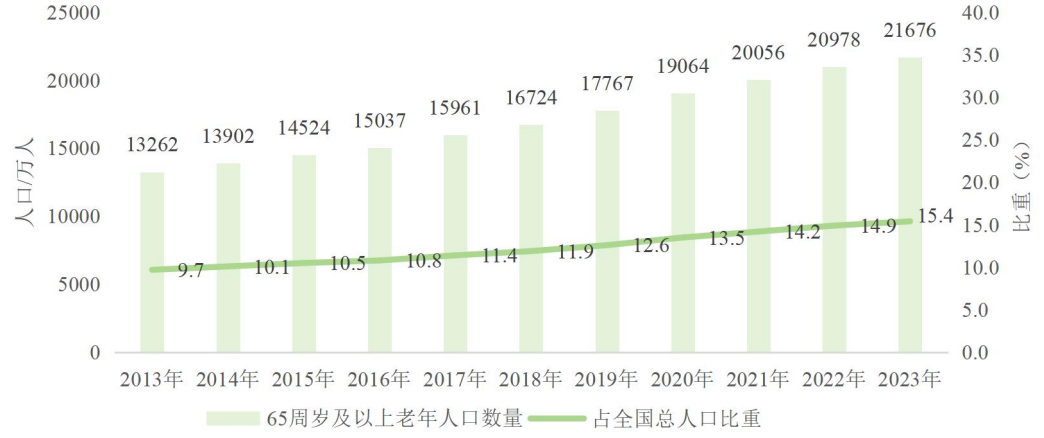
截至2023年末，全国60周岁及以上老年人口29697万人，占总人口的21.1%；全国 65 周岁及以上老年人口 21676 万人，占总人口的 15.4%，全国 65 周岁及以上老年人口抚养比 22.5%。

图表 1：2013 年—2023 年全国 60 周岁及以上老年人口数量及占全国总人口比重



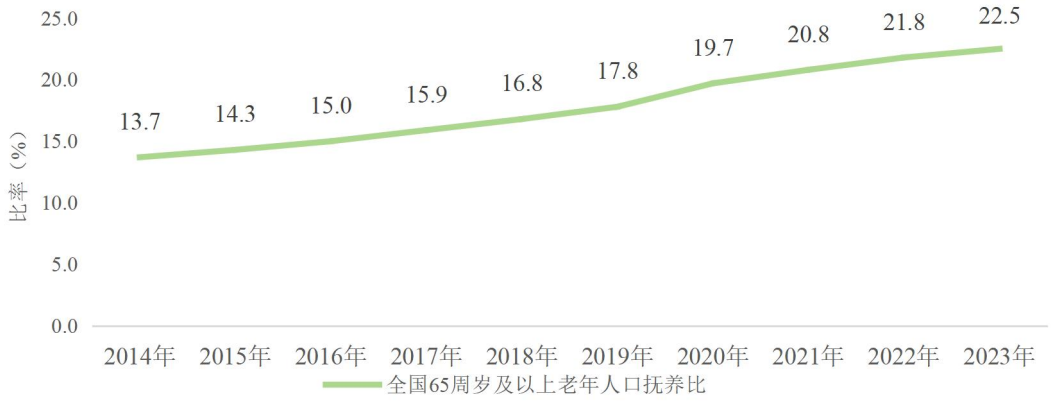
来源：国家统计局

图表 2：2013 年—2023 年全国 65 周岁及以上老年人口数量及占全国总人口比重



来源：国家统计局

图表 3：2013 年—2023 年全国 65 周岁及以上老年人口抚养比



来源：国家统计局

预计到 2033 年，中国老年人口将突破 4 亿，占总人口的 1/4，到 2053 年达到峰值 4.87 亿，占比超过总人口的 1/3。尤其是第二代婴儿潮（出生的人口）即

将步入养老阶段，这为银发经济的发展提供深刻的人口基础。第一代婴儿潮（1949年—1957年新中国成立后出生的人口）目前处于66—74岁的年龄段，已经步入养老阶段，第二代婴儿潮（1962年—1975年出生的人口）是我国规模最大的婴儿潮，年均出生人口超2500万，目前他们正处于48岁至61岁的年龄段，掌握着较多的社会财富，未来的5～10年内将有大批人口步入养老阶段，**银发产业的潜力也将在未来5～10年内快速释放**。

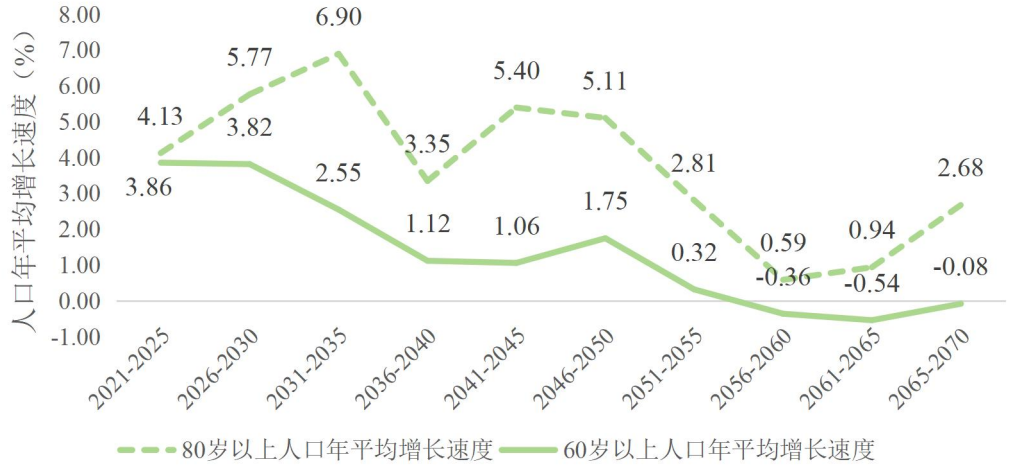
1.1.2. 老龄化进程快

中国老龄化的速度在全球范围内属于较快水平。从2001年65岁及以上人口超过7%，标志着进入老龄化社会，到2021年65岁及以上人口占比超过14%，中国仅用了21年的时间，这一速度短于法国的126年、英国的46年、德国的40年。预计到2033年左右，中国65岁及以上的老年人口占比将超过20%，进入超级老龄化社会。之后，这一比例将持续快速上升至2060年的约37.4%。在总和生育率不同的假设下[①]，2057年中国65岁及以上人口将达到4.25亿人的峰值，占总人口比重32.9%～37.6%。根据预测，2022—2036年将成为老年人口增长最快的时期，2037—2051年进入中速增长阶段，因此**未来30年是积极应对人口老龄化、解决老龄问题的关键时期**。

此外，由于老年人死亡率的下降和预期寿命的延长，会出现年龄越大人口增长速度越快的情况。根据下图中所预测的未来60岁、80岁及以上人口年平均增长速度可以看出80岁及以上高龄老人的年平均增长速度大大高于60岁及以上老年人的增长速度，从2030年到2035年，高龄老人年平均增长速度达到最高点6.90%，比60岁及以上老年人年平均增长速度最高点的3.86%高出了3.04个百分点。高龄老人年平均增长速度的第二个高点将出现在2041—2045年，为5.40%；第三个高点将出现在2070年，为2.68%。这三个高点与三次人口出生高峰在时间上是完全对应的。高龄老人增长速度大大快于老年人的增长速度，这使得未来高龄老人数量、高龄老人占老年人口比例、高龄老人占总人口比例都会快速提升。

① 总和生育率（Total Fertility Rate，简称TFR）是指一个女性在育龄期间（通常从15岁到49岁）预期生育的孩子总数。是衡量生育水平的重要指标，常用于预测人口增长和变化趋势。不同的TFR假设反映了对未来生育率的不同预期。

图表 4：未来 60 岁、80 岁及以上人口年平均增长速度预测



来源：2020 年第七次全国人口普查

1.1.3. 高龄化严重

高龄化是人口老龄化过程中的一个显著趋势，具体指**80 岁及以上的老年人口在整体老年人口中所占比例的持续上升**。预计到 2035 年和 2050 年，中国 80 岁及以上的高龄老人数量将分别增至 8256 万和 15962 万，占总人口比重分别达到约 6%和约 12%。中国高龄老人的比重将显著增加，对社会养老服务的需求将大幅提升。

随着高龄老人数量的增加，失能老人的数量也在同步增长。随着人口老龄化，失能人口老龄化的挑战成为我国日益突出的问题。1987 年我国失能人口年龄段分布均衡，但是到了 2006 年，失能人口分布开始向老年人转移。据全国老龄办、民政部、财政部发布的第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查结果，我国失能、半失能老年人大致 4063 万人，占老年人口 18.3%。研究估计，到 2030 年，我国失能人口预计会增长为 1.3624 亿到 1.3674 亿，预计到 2030 年失能老龄人口在总失能人口中的占比将超过 57%，如果不施加预防以及控制措施，该比例将在 2050 年进一步增长到 70%以上。

1.2. 人口老龄化带动“银发经济”发展

在医疗科技不断进步、生活水平不断提高的背景下，我国人均预期寿命持续增加，对我国的人口结构、社会形态、家庭模式及生活方式带来了深远的影响，

人口老龄化的结构性变化和社会特点也催生了银发经济发展的机遇。例如，促进老年人社会参与活力，推动社会养老事业建设，鼓励产业多元化发展，以及提升政策福利支持，进一步提高中国老人生活福祉等。

银发经济是向老年人提供产品或服务，以及为老龄阶段做准备等一系列经济活动的总和，涉及面广、产业链长、业态多元、潜力巨大。下文从**需求理论**和**行业关系**两个视角对**银发经济产业链**进行了简要分析，并据此进一步聚焦**“养老照护服务”**行业，探索行业、企业的发展与变革。

1.2.1. 需求理论视角

银发经济是围绕老年群体的需求形成的经济活动，将银发经济视为由老年人的四种需求驱动的经济，分别涉及**生理需求、健康需求、情感需求与自我实现需求**，可得到其相应的产业图谱。

图表 5：中国银发经济市场产业图谱一览



来源：招商证券

其中，银发经济的基础是老年人的基本生活需求，这部分需求将最先获得关注，最先被要求满足，故相关行业的发展将走在前列，包括**养老照护服务**、养老设施和机构、老年房地产等。据程明梅、杨华磊的预测，未来城镇重度失能老年人养老服务人员需求数量处于上升状态，预计 2050 年以前其每年需求的平均规模会超过 500 万人，因此应尽快建立覆盖城镇居民的长期照护机制，针对不同的城镇失能人群构建差异化的长期护理模式，加快建设针对城镇失能老年人的专业照护人员队伍，完善失能老年人养老服务规制。养老照护服务行业需求迫切，发

展前景广阔。

而随着老年人生活水平的提高和消费观念的变化，银发经济开始向更高层次发展，涵盖了老年服饰、老年食品、老年医疗等消费领域。此外，银发经济还包括了智慧养老、老年教育、老年旅游等新兴领域，智慧养老利用现代信息技术，为老年人提供智能化、便捷化的养老服务，老年教育和旅游则满足了老年人精神文化生活的需求。

1.2.2. 行业关系视角

养老产业围绕老年人全方位需求，**涵盖多元产业体系**。上游包括医疗设备器械、食品与药品等基础产品制造；中游以养老服务为核心，包括居家养老、社区养老、机构养老；下游为用户人群和营销渠道。

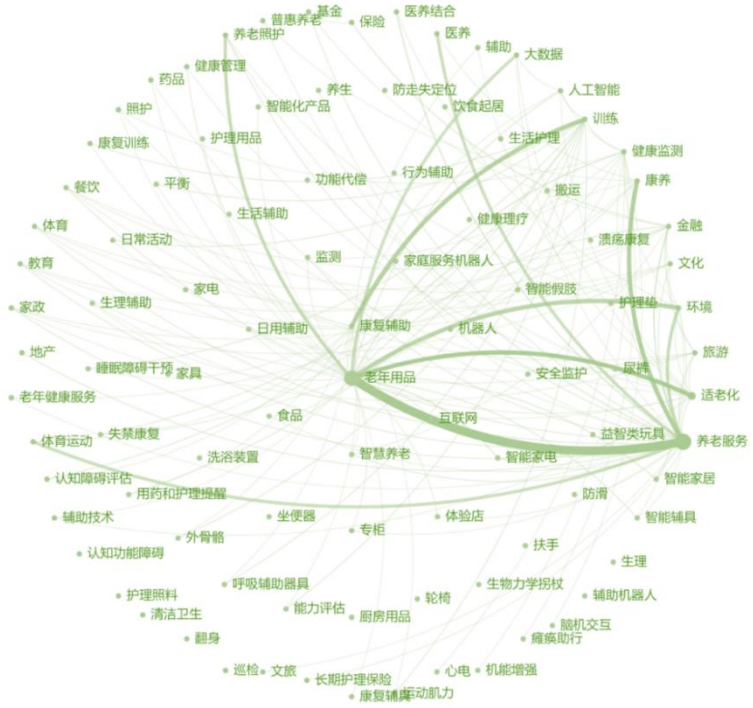
图表 6：养老产业链



来源：前瞻产业研究院，长生不老小组绘制

着眼带有“银发经济”字样的政策文件，将文件中涉及银发经济的语句或段落摘录出来，并进行**关键词网络分析**，可以得到下图。其中**“养老服务”**（最右端）与多方面内容联系紧密，**与多个细分行业产生互动**。具体来看，政策尤其关注居家、机构养老的服务体系建设，强调通过补贴、投资、人才、用地等方式的支持，建立居家和机构养老系统，推动护理、医疗、教育、智慧化、信息化与养老服务的协同。

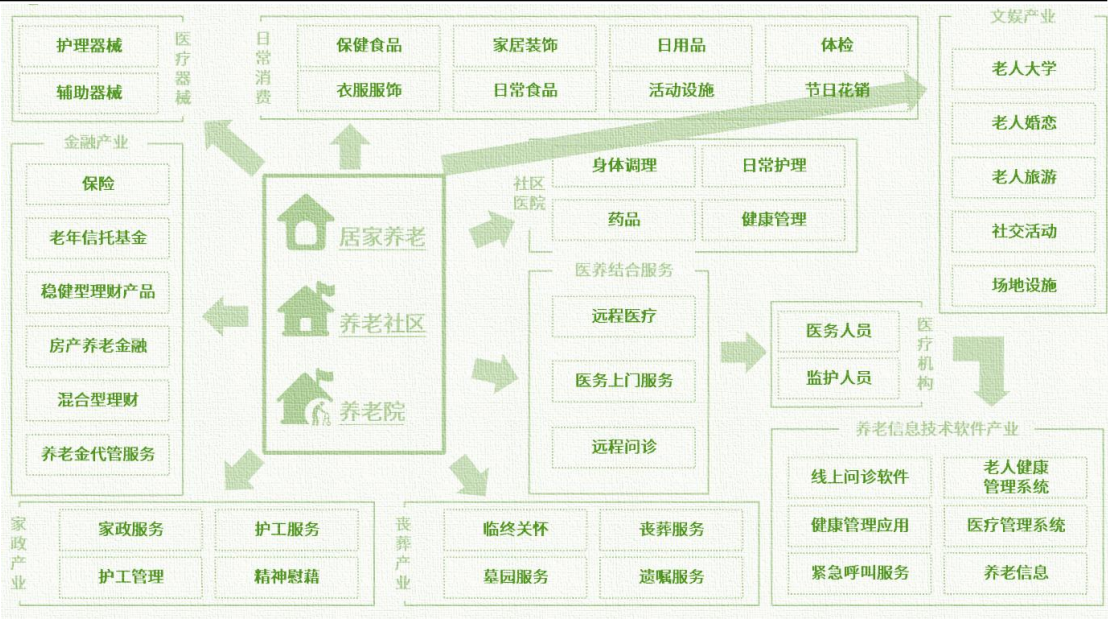
图表 7：政策文件中所包括的银发经济关键词分类网络关系图



来源：平安证券

养老照护服务是**养老产业链中的核心环节**，是**联结其他产业的关键节点**。养老照护服务**接近 C 端**，直接面向老年人日常生活需求，与老年人健康管理、生活消费等多个方面产生密切连接；通过照护服务，企业可以深入了解老年人的需求和偏好，为其他产业提供精准的导流支持，比如推荐适老化硬件、健康食品、养老保险等。进一步地，养老照护服务行业中的**平台型企业**能够积累大量数据（如健康状况、消费情况等），为上下游产业提供**资源整合**和**精准营销支持**，推动整个**养老生态链协同发展**。例如，在下图中，依托与家庭、社区、机构等实体，养老照护行业可充当“超市”“枢纽”角色，充分发挥其**平台组织性**，通过信息化技术，整合医养结合产业（医疗机构、医疗器械、社区医院、养老信息技术软件）、日常消费产业、文娱产业、家政产业、丧葬产业、金融产业等，为老年群体提供一站式服务。

图表 8：中国银发经济产业链



来源：艾媒咨询

2. 养老照护服务行业

2.1. 养老照护服务行业宏观环境分析

2.1.1. 政治环境（Political）

我国高度重视老龄化问题，并将积极应对人口老龄化上升为国家战略。在顶层设计方面强调养老照护行业的重要性。政府大力推动发展民生事业、扩大产品供给、聚焦多样化需求、培育潜力产业，以推动银发经济的规模化、标准化、集群化、品牌化发展。国家在鼓励民营资本参与的同时，也致力于加强政府的主导地位，保障银发经济服务体系的稳定，在提供设施、引导参与、促进产业联动发展等方面发挥着不可或缺的作用。根据民政部数据，“十四五”时期，民政部组织实施居家和社区基本养老服务提升行动项目，已支持 184 个项目地区建设 34.7 万张家庭养老床位，提供 64.7 万人次居家养老上门服务。落实“十四五”规划纲要部署，推动各地在县区层面建成 413 个示范性社区养老服务网络。

2019 年老龄政策“层级高、力度大、综合系统、立体多元”，养老服务政策更是实现了整体性突破，主要标志是 4 月份国务院办公厅印发**《关于推进养老服务发展的意见》**，出台 28 条具体政策措施，其中两方面最突出：一是**深化“放**

管服”改革。主要包括建立养老服务综合监管制度，继续深化公办养老机构改革，通过提高审批效能解决好养老机构消防审验问题，减轻养老服务税费负担，提升政府投入精准化水平，支持养老机构规模化、连锁化发展，做好养老服务领域信息公开和政策指引等 7 项措施。二是**拓展养老服务投融资渠道**。主要包括推动解决养老服务机构融资问题，扩大养老服务产业相关企业债券发行规模，全面落实外资举办养老服务机构国民待遇等 3 项措施。6 月份财政部、民政部等 4 部委发布《关于养老、托育、家政等社区家庭服务业税费优惠政策的公告》，明确关于养老服务税收优惠政策，同时民政部联合财政部继续开展居家社区养老服务改革试点。养老服务政策不断完善，涵盖了护理从业人员管理到养老服务优惠补贴等多个维度，政策的有效供给大大增加，逐步实现由数量增长向质量提升的过渡。

2021 年—2023 年，中央财政累计下达彩票公益金 79.88 亿元，用于支持城乡养老服务设施改造、居家社区养老服务组织培育等；实施公办养老服务机构能力提升项目，鼓励公办养老服务机构采取公建民营等方式提升养老服务运营效率。

图表 10：2019 年以来国家层面重要政策解读

时间	发布部门	政策名称	主要政策内容	政策类型
2019.03	国务院	《关于推进养老服务发展的意见》	政策表示要保持养老机构规模化、连锁化发展，推动解决养老服务机构融资问题，提升医养结合的服务能力。推动居家、社区和机构养老融合发展，支持养老机构运营社区养老服务设施，上门为居家老年人提供服务。实施“互联网+养老”，在全国建设一批“智慧养老院”，推广物联网和远程智能安防监控技术，形成示范效应。	指导类
2020.11	国务院	《关于建立健全养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的意见》	1）加强涉及资金监管：引导养老服务机构以合法合规方式筹集和使用养老服务涉及资金。	指导类
			2）加强运营秩序监管：引导养老服务机构不断优化内部管理、规范服务行为，合理规避风险、妥善处置纠纷。	
			3）压实机构主体责任。养老服务机构应当不断提高养老服务、安全管理、风险防控、纠纷解决的能力和水平。	
			4）发挥标准规范引领作用：建立健全养老服务标准和评价体系，实施养老机构服务质量、安全基本规范等标准，引领养老服务高质量发展。养老服务设施应严格执行国家工程建设技术标准规范。	
2021.03	中共中央、国务	《中华人民共和国国民	1）大力发展普惠型养老服务，支持家庭承担养老功能，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。	支持类

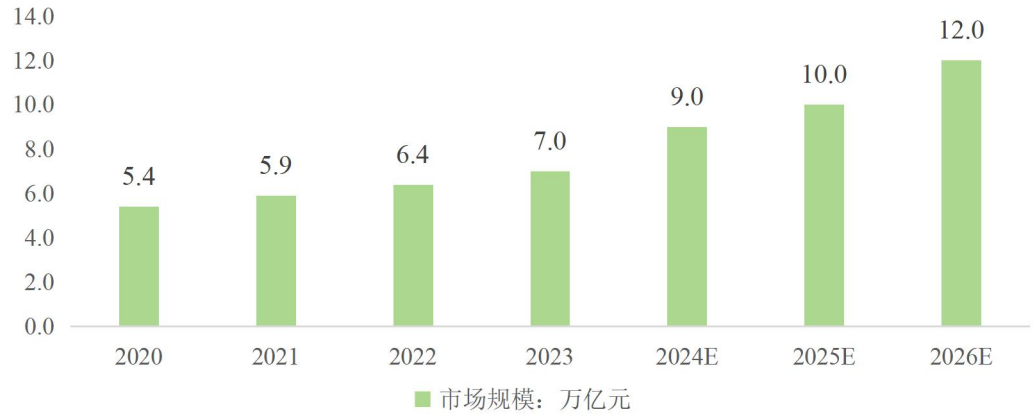
时间	发布部门	政策名称	主要政策内容	政策类型
	院	经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	2）完善社区居家养老服务网络，推动专业机构服务向社区延伸，整合利用存量资源发展社区嵌入式养老。	
			3）支持培训疗养资源转型发展养老，加强对护理型民办养老机构的政策扶持。	
			4）加大养老护理型人才培养力度，养老机构护理型床位占比提高到 55%，更好满足高龄失能失智老年人护理服务需求。	
			5）积极发展农村互助幸福院等互助性养老。	
2021.11	中共中央、国务院	《关于加强新时代老龄工作的意见》	从健全养老服务体系、完善老年人健康支撑体系、促进老年人社会参与、百力构建老年友好型社会、积极培育银发经济、强化老龄工作保障和加强组织实施等方面， 对新时代老龄工作作出部署。	指导类
2021.12	中共中央、国务院	《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》	1）制定“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系主要指标，规定养老服务床位总量、养老服务设施达标率等远景目标	支持类
			2）推动养老服务体系高质量发展，完善养老保险、保险、长护险制度，加快补齐农村养老服务短板。提升医养结合能力	
			3）推动老龄事业和产业协同发展，大力发展银发经济，打造老年友好型社会，壮大老年支持的人才社会体系	
来源：国务院，财政部，人社部，民政部等国家部委平台				

2.1.2. 经济环境（Economic）

2.1.2.1. 市场规模与支付能力

我国银发经济市场规模持续扩张，2022 年已达约 9.4 万亿元。随着人口老龄化的加剧，银发经济需求不断增长，蕴含巨大的市场潜力。根据《中国城市养老服务需求报告（2021）》，预计到 2030 年，全国老年人口消费总量约为 12 万亿元至 15.5 万亿元，与全国 GDP 的比率将提高至 8.3%至 10.8%。**到 2050 年，这一数字将达到 40 万亿元至 69 万亿元，占 GDP 的比率提高至 12.2%至 20.7%**。在细分市场中，例如智慧养老，市场规模在 2022 年已达到约 8.2 万亿元，同比增长 34.43%。此外，中国中老年服装市场规模在 2023 年达到 1581 亿元，同比增长 10.02%，预计 2025 年将超过 2000 亿元。

图表 11：2020—2026 年中国银发经济市场规模趋势预测



来源：2024 年中国银发经济行业市场规模及行业发展前景预测分析，弘博报告

养老照护服务需求与家庭经济状况密切相关，具体包括老年人的退休金、储蓄和其他资产情况，以及子女对养老服务的支付能力。随着中国经济增长和居民收入提高，尤其是中产阶级群体的扩大，家庭支付智能设备和护理服务等高质量养老服务的能力逐渐增强。然而，养老成本依然较高，据中国老龄科学研究中心统计，约 50%的老年人将超过家庭收入的 30%用于养老，这说明经济基础是养老照护行业可持续发展的重要决定因素。

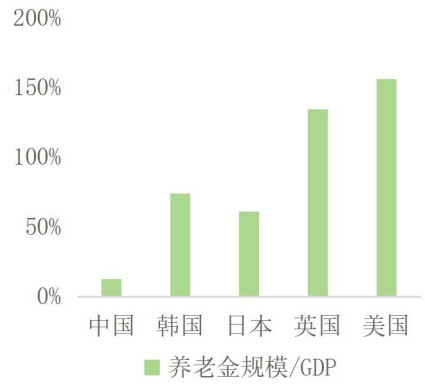
尽管如此，我国老年人口的支付能力总体仍偏低，加之城乡经济差异和养老资源分布不均，进一步制约了养老照护服务的需求。农村地区由于财政和医疗资源不足，养老主要依赖家庭照顾，但随着农村人口外流，许多老人被迫独居或留守，难以获得专业护理服务，城乡间养老服务供给差距明显。现有社会救助和福利保障范围较窄，主要集中在特困老年人和部分经济困难的失能老年人，保障水平有限。为推动养老照护服务发展，提高老年人支付能力、扩大社会保障覆盖面是关键举措。

2.1.2.2. 养老照护服务行业的资金困境

一方面，我国**养老资金准备不足**，面临未富先老的问题。2020 年，由中国保险行业协会发布的《中国养老金第三支柱研究报告》指出，未来 5～10 年时间，中国预计会有 8 万亿-10 万亿的养老金缺口，且缺口将随时间推移进一步扩大。从养老金规模/GDP 来看，2020 年我国养老金规模/GDP 仅为 12.4%，而日韩英

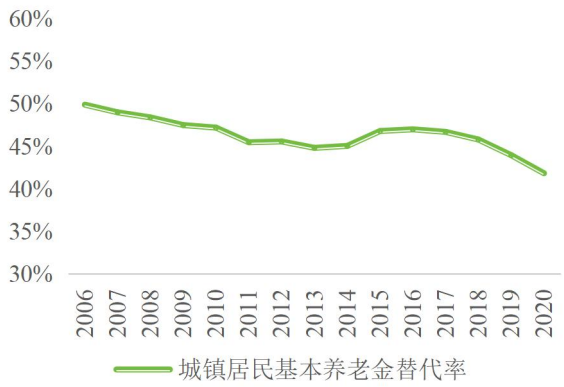
美等国均接近甚至超过 100%，这表明我国**养老金存量规模较发达市场仍有明显差距**。除此之外，我国**基本养老金替代率近年来呈下降趋势**，2020 年仅有 41.3%；而国际公认的比较适合的养老金替代率为 70%～85%，国际劳工组织认定 55%是养老金替代率的警戒线，低于此水平的退休后生活质量将显著下降。

图表 12：2020 年各国养老金规模



来源：Thinking Ahead Institute

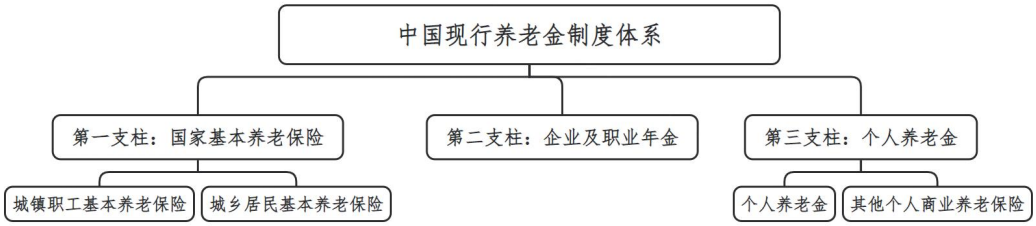
图表 13：我国城镇居民基本养老金替代率历年变化



来源：泽平宏观

另一方面，我国**养老金体系不完善**，存在结构性失衡、覆盖率不足、发展缓慢等问题。我国养老金运营体系采用“三支柱”模式，第一支柱是由政府主导的基本养老保险，第二支柱是企业职业年金，第三支柱是个人自愿的养老投资。截至 2021 年末，我国养老金第一，二，三支柱分别占比 70%、30%、0%左右，呈现**第一支柱“一枝独大”、第二支柱覆盖面小、第三支柱尚处于起步阶段**的特点。我国对养老金第一支柱依赖过高，给政府财政压力过大，存在较大可持续风险；第二支柱覆盖人群有限，截至 2023 年末，我国参加企业年金的职工仅占全国城镇就业人口的 6.68%，而 OECD 国家的企业年金整体覆盖率接近 60%；此外，我国第三支柱个人养老金制度长期滞后，在发达国家人均保费缴纳额高达 3000 美元，而中国仅为 27 美元。

图表 14：我国现行养老制度体系



来源：《美德日个人养老金制度及其对中国的启示》

图表 15：各国养老三大支柱体系图示

		中国	日本	美国
第一支柱	名称	城镇职工基本养老保险 城乡居民基本养老保险	国民年金 厚生年金	强制性联邦公共养老金计划（OASDI）
	占比	70%	58%	8%
第二支柱	名称	企业年金 职业年金	退职金制度（LSSB） 中小企业退职金共济制度（Chutaikyo） 收益确定型年金（DB） 缴费确定型年金（DC）	自愿型雇主养老金计划（DB 计划和 DC 计划）
	占比	30%	35%	53%
第三支柱	名称	个人储蓄型养老保险 商业养老保险	国民年金基金 个人缴费确定型养老金计划（iDeCo)	个人养老储蓄计划（IRA 及其他）
	占比	0%	7%	32%
备注		德日模式以第一支柱为主 英美模式以第二支柱为主，依赖成熟的资本市场建立完善的私人养老金体系		

来源：艾瑞咨询、中国社会保障学会

2.1.2.3. 对相关产业的带动效应

养老照护服务不仅涉及家庭和个人的支出问题，同时也带动多个相关产业的发展。健康管理设备（如心电监测仪、血压计等）、智能监护设备（如智能床垫、居家安全传感器）以及家政护理行业的快速发展，正在逐步形成规模化的经济产业链，市场需求也迅猛增长。以智能设备为例，智能手环、智能护理床、自动报警系统等科技产品的研发为老年人提供了更安全、便捷的生活支持，此类技术产品既满足了家庭护理的需求，也带来了养老照护服务的新经济增长点。养老服务

行业的兴起也创造了新的就业机会。根据人力资源和社会保障部的数据，养老服务行业已成为劳动密集型行业，预计到 2025 年将创造约 1000 万个就业岗位。

2.1.3. 社会环境（Social）

老年人口增长加剧了养老需求的多元化和高品质化趋势。老龄化与少子化使老年抚养比上升，“养儿防老”难以为继，独生子女家庭的“4-2-1”模式让许多夫妻需照顾四位老人，而子女在城市的高压环境进一步限制了照护能力。随着家庭小型化和多样化，传统大家庭逐渐被核心家庭或单身家庭取代，家庭照护能力下降，独居或缺乏照护的老年人增多，刺激了专业养老照护服务的需求。新的养老模式既满足了老年人居家养老的愿望，也缓解了家庭的照护压力。

社会对养老照护的支持持续增强，社区、企业等通过灵活多样的形式提供涵盖医疗护理、生活照料、心理支持等服务。老年人对居家养老服务的接受度提高，社会对老年人的尊重与关怀逐步加深。近年来，社区心理健康辅导和活动帮助老年人维持心理健康与身心愉悦，体现了养老服务从生理到心理的全方位关注。

2.1.4. 技术环境（Technological）

人工智能、物联网、大数据、云计算等上游技术成果为养老照护提供了充分的技术支持，能够提供智能化、物联化、个性化的养老服务。随着技术的发展，智慧健康养老产品的供给能力明显提升。健康管理、康复辅助、养老监护等智能产品种类不断丰富，产品质量与性能持续提升，应用场景进一步拓展，服务内容进一步丰富，服务模式进一步创新，《中国养老科技发展报告》显示，智能养老设备的普及率在城市老年人群体中已达到 35%，并且呈上升趋势。养老照护服务中技术设备的应用不仅可以提高安全性，还能减轻家庭照护的负担。此外互联网平台和移动应用的普及，也为养老服务提供了便捷的信息交流和资源配置渠道，提供了更加多样丰富的服务模式。

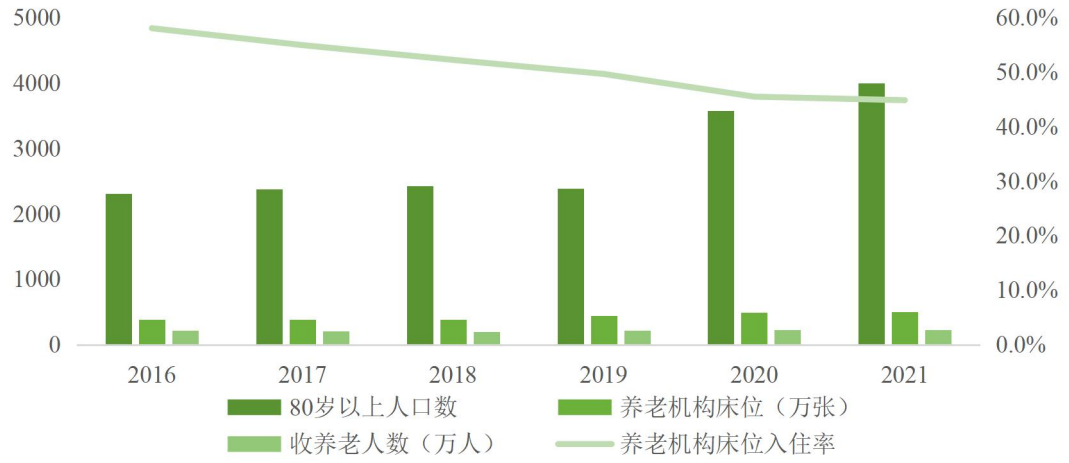
2.2. 养老照护服务行业市场情况

1）**需求侧，老年服务资源需求旺盛。**截至 2023 年底，我国 60 岁以上老年人口有 2.97 亿，其中 75%至少患有一种慢性病，18.3%处于失能、半失能状态。

据中国老龄办 2015 年发布的抽样调查结果，全体老人需要照护的人群比例由 2000 年的 6.6%上升至 15.3%，其中 80 岁以上老人需要照护的比例增至 41.0%，较 2000 年上升近一倍。老年人需要照护比例的上升趋势迅猛。

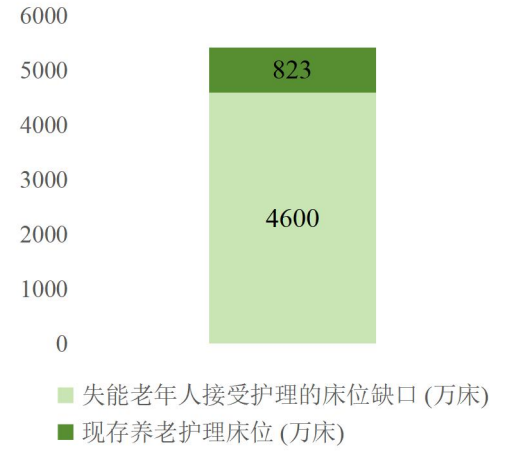
2）**供给侧，我国养老基础设施和专业护理人员都存在巨大缺口。设施方面，**截至 2023 年底，全国共有各类养老机构和设施 40.4 万个，养老床位合计 823 万张，每千名 60 岁以上老年人拥有养老床位仅有 27.7 张。这意味着，包括居家护理及入住专业照护机构在内，失能、半失能老年人接受护理的床位缺口约达到 4600 万。**护理人员方面，**按照我国失能老人与护理员 5:1 的配置标准推算，护理人员需求约在 1100 万人；而截至 2021 年底，全国养老护理从业人员仅 50 万。同时，受制于社会认知、薪资水平及工作强度等因素，养老护理员从业者一直存在学历偏低、技能水平不足等现象，在培训过程中则存在招生难、留人难、职业通道不通畅三大问题。

图表 16：2016—2021 年养老有效需求与床位供给情况



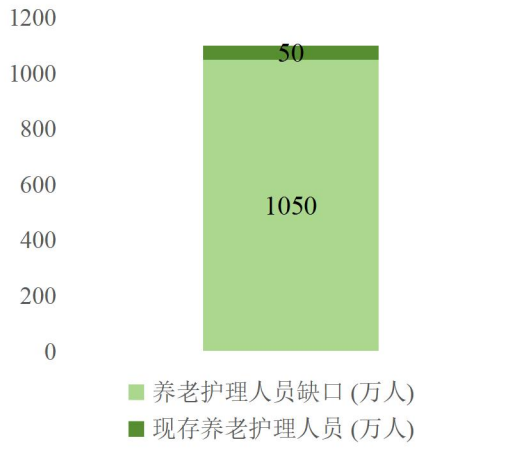
来源：国家统计局人口抽样数据推算，2022 中国民政统计年鉴

图表 17：2023 年老年人护理床位缺口



来源：艾瑞咨询

图表 18：2023 年养老护理人员缺口



来源：艾瑞咨询

3）总体来看，养老服务行业存在供需不匹配的状况。截至 2019 年，中国的老年人市场年需求消费能力已经达到或超过 6000 亿元，而每年能为老年人提供的产品供给尚不足 1000 亿元，这表明养老服务行业未来有巨大的发展空间。

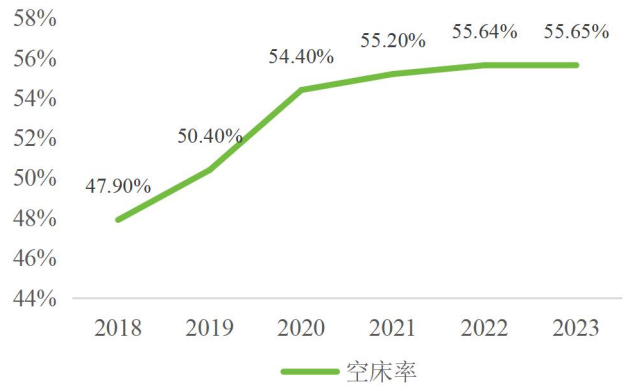
3. 居家养老照护行业

3.1. 居家模式将成为未来养老照护行业主流

据《养老产业统计分类（2020）》，养老照护服务包括**居家、社区和机构养老**照护服务三类养老模式。居家养老指家庭护理或非社区的上门服务；社区养老指日间照料和各类社区服务；机构养老主要是各级政府、企业和社会力量兴办的养老机构提供的集中养老服务。

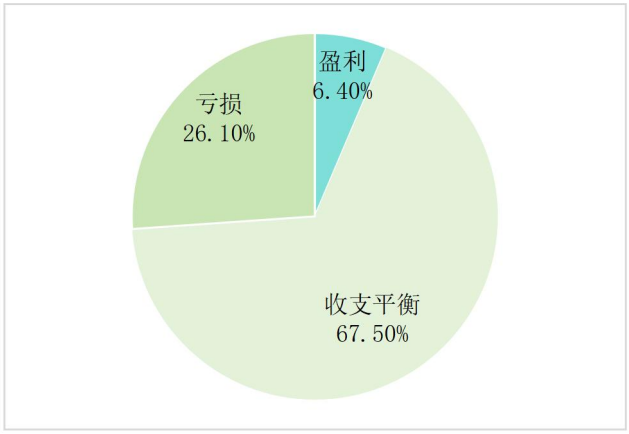
我国机构养老存在较大的经营困境。机构养老以重资产运营模式为主，前期投入高、回报周期长，养老机构只能向客户转移这一固定成本，导致居民获得养老服务的门槛升高，付费意愿下降。根据 2021 年发布的《第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查》，仅有 15.8%的老人能承受每月 3000 元及以上养老机构费用。加之传统养老观念深厚、养老机构基础设施薄弱等因素的影响，我国养老机构经营状况不佳，近年来我国养老机构空床率始终在 50%以上，且有上升趋势；2021 年我国养老机构仅 6.4%实现盈利，绝大多数养老机构处于收支平衡甚至亏损的状态。

图表 19：2018—2023 年我国养老机构空床率



来源：中国消费者协会

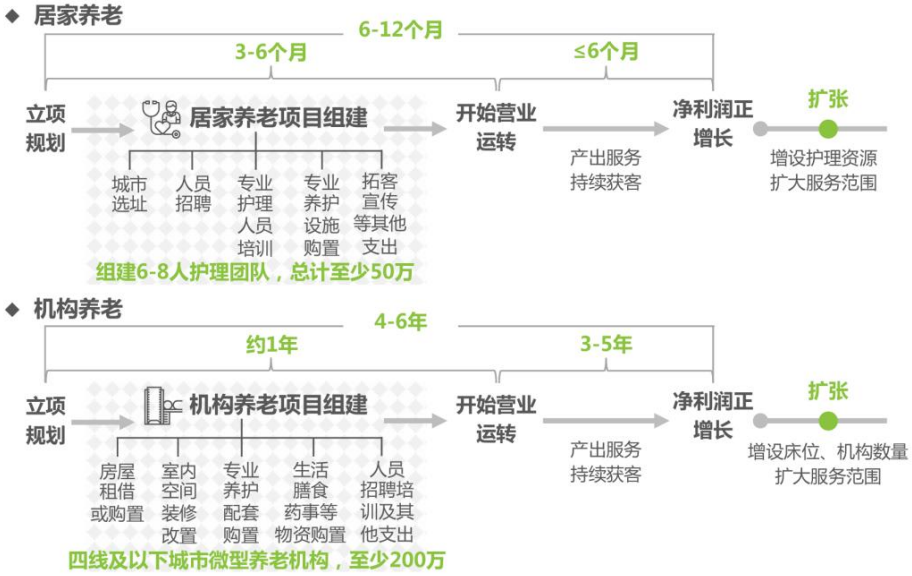
图表 20：2021 年整体市场养老机构盈亏状况



来源：中国消费者协会

相比之下，**居家养老**属于轻资产运营模式，建设周期短、投入成本低，更适合我国老人养老金储备不足的国情。此外，据《中国城市养老服务需求报告(2021)》，有近八成受访者在未来更倾向于选择熟悉且舒适的环境，在“家门口”实现居家及社区养老。

图表 21：机构养老和居家养老商业模式对比



来源：艾瑞咨询整理

我国居家养老的模式经过了家人和保姆模式，正向中介模式和专业居家护理模式转变。随着我国家庭结构逐步向“4-2-1”转变以及子女离乡流动的加大，家庭照护的提供者由家人逐步向平台、专业护工转移，未来市场潜力巨大。

图表 22：我国居家养老的三种主要模式



来源：艾瑞咨询整理

目前我国已形成“9073”养老模式，即 90%左右的老年人都在居家养老，7%左右的老年人依托社区支持养老，3%的老年人入住机构养老。**未来，以居家为中心，设施、人员、服务等嵌入的养老模式将成为我国养老照护行业的主流。**

3.2. 居家养老照护行业的特点

3.2.1. 行业发展处于早期阶段

我国目前的居家养老服务提供商，融资普遍处于早期阶段，融资金额较低，没有上市公司。**行业高度分散，以初创型企业为主**，既有聚焦日常照料和康护服务的机构（如福寿康、青松康护、二毛照护等）、或专注智慧照护解决方案的机构（如麦麦等），也有线上线下相结合、提供智慧养老解决方案和居家养老服务的机构（如安康通等）。

图表 23：国内头部居家养老服务提供商基本情况介绍

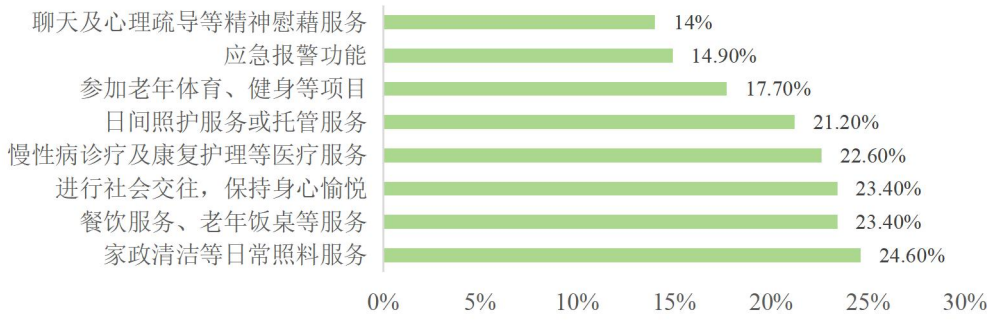
企业名称	成立时间	最新一轮重大融资	基本介绍
福寿康	2011	2022 年，C 轮+融资上亿元	居家医养照护服务商，开创“护理站+日托/长者照护之家”模式，提供护理、医疗、康复、认知症照顾、辅具租赁、适老化产、护理员培训服务。
小橙长护	2018	2023.12，B 轮融资数千万（A 轮、Pre-A 均为数千万）	集“养老护理服务、医养人才培养、数字化医养平台”为一体，提供生活照料、医疗护理、病患

			管理、康复理疗，以及辅具租赁、适老化改造、护理员培训等服务。
璞缘照护	2017	2023.03，A 轮融资数千万元	专注居家护理养老服务，在全国 30 个城市连锁布局长护定点业务，以社区为依托，承接多地社区日照、养老服务中心、养老驿站的运营服务。
青松康护	2009	2016 年，B 轮数千万美元	康复护理服务机构，专门服务于居住在家中和社区内的老年人、残疾人、病后术后康复期人群，提供专业规范的长期照护和康复护理服务。
小柏家护	2015	2015.12，Pre-A 轮融资 3000 万元；2018.01，战略投资金额未披露	为老人提供医院陪护及居家护理服务，涉及术前、术后疾病期急性期护理、居家慢性病照护以及院后疾病恢复期护理等服务
颐家养老	2013	2023.12，B 轮数千万元	为社区老人提供医、护、康、养、险服务，通过机构、站点、居家等多种服务模式，形成特色的“医养服务平台网络”，实现“全人 、全龄、全家、全程”照护服务。
二毛照护	2015	2016.03，天使轮数百万美元	主要面向高龄、失能、失智人群，为用户提供生活照护、病症护理 、病后康复等方面一站式居家照护服务。公司业务主要包括整月照护、全天照护、失智照护以及分时照护。
小羊养老	2022	2022.08，天使轮数百万元融资	专业的陪诊业务和适老化改造业务是小羊养老目前最主要的服务。
抚理健康	2016	2021.09，A 轮未披露	专注于为商业保险+长护险客户提供一体化专业康护服务。
清檬养老	2014	未融资，获得奖项较多	自主研发养老人才教育培训体系和智慧照护体系，提供 24 小时居家 照护服务、社区托管照护服务、上门服务、康复护理以及疗养度假服务。
来源：艾年咨询			

3.2.2. 老人需求未被充分满足

居家养老的老人需求度的服务种类最高的是家政、清洁等日常照料服务，占比 24.6%，其次是餐饮、老年饭桌等服务，再次是社会交往的服务需求。

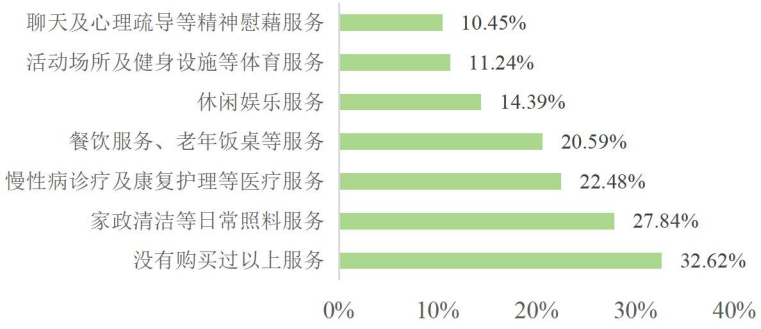
图表 24：居家养老主要服务需求



来源：中国消费者协会

总体来看，**居家老人对服务的需求并未被充分满足**。32.62%的老人没有购买过上述所需服务，且老人的目前消费情况和上文提到的真实消费需求存在错配。此外，服务需求满足程度存在地区分布不均衡的问题，中部城市老人购买使用各类居家养老服务的比例最低，尤其是法律咨询或援助服务、知识讲座及书法绘画等文化教育服务和聊天及心理疏导等精神慰藉服务的购买和使用率最低。

图表 25：购买使用过的居家养老服务



来源：中国消费者协会

图表 26：不同地区购买使用过居家养老服务

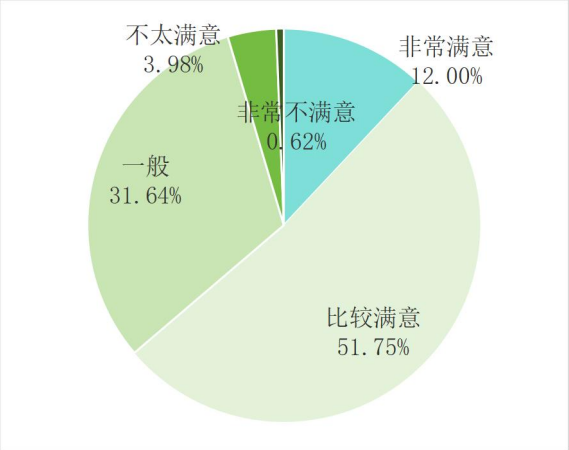
服务	东部	中部	西部
餐饮服务、老年饭桌等服务	27.20%	7.80%	14.70%
慢性病诊疗及康复护理等医疗服务	23.50%	21.00%	21.00%
聊天及心理疏导等精神慰藉服务	12.40%	2.10%	13.20%
家政清洁等日常照料服务	28.20%	27.50%	27.10%

知识讲座及书法绘画等文化教育服务	11.50%	0.50%	6.10%
活动场所及健身设施等体育服务	14.40%	4.10%	9.30%
法律咨询或援助等法律服务	11.10%	0.30%	3.90%
休闲娱乐服务	17.10%	6. 2%	14.70%
没有购买过以上服务	22.70%	51.80%	41.30%

来源：中国消费者协会

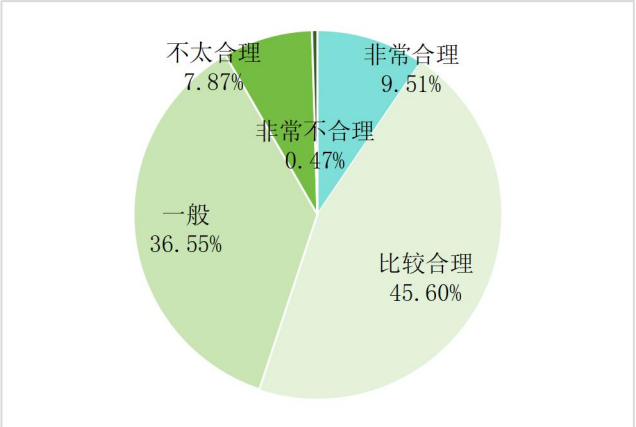
当被问及对居家养老服务**质量满意度**，仅有 12%的消费者对服务质量表示非常满意，6.24%的消费者对居家养老服务质量表示一般或不满意，对质量水平存疑。同时，居家养老服务**收费合理性**有待提升，仅有 9.51%的老人表示非常合理，36.55%的老人对收费合理性表示一般，认为不合理的比例达到 8.34%。

图表 27：居家养老服务质量满意度水平



来源：中国消费者协会

图表 28：居家养老服务收费合理性评价



来源：中国消费者协会

总体来看，当前已有的居家养老服务并不能满足老人的需求。未来，服务种类、服务质量和收费合理性都有望进一步提升，我国居家养老市场增长潜力巨大。

3.2.3. 和保险结合紧密

当下，老年人群体中低支付能力占比较高，整体支付缺口逐渐加大，支付端的创新是解决这一问题的重要抓手，未来保险将成为居家养老的重要资金来源。

3.2.3.1. 政策性长护险

长护险是为年老、疾病或伤残导致日常生活不能自理的失能人员，提供基本生活照料和与之密切相关的医疗护理服务或资金保障的一项社会保险制度，被称为社保“第六险”。2016 年，我国确定了 15 个城市作为长护险制度的首批试点城市；截至 2024 年 10 月，全国 49 个长护险试点城市的参保覆盖约 1.8 亿人，累计超过 235 万人享受长护险待遇。

参保人群上，长护险通常与基本医疗保险相挂钩，多数地区长期护理保险制度首先从职工医保参保人群起步，重点解决重度失能人员基本护理保障需求。以上海为例，参与职工医保的人员或参与居民医保的 60 岁以上的人员都强制参保。

筹资方式上，职工医保参保人员筹资多从职工医保基金和职工医保个人账户划转，也有部分地区给予财政补助。居民医保参保人员筹资渠道主要包括个人缴费、财政补助、医保基金划转等方式。总的来说，医保统筹基金划转依然是长期护理保险制度主要的筹资来源。

支付待遇上，待遇支付标准大多偏重居家护理模式，总体基金支付水平在70%左右，上海、广州、青岛等城市部分报销比例达到 80%以上。此外，大多数地区都采取服务给付的方式，即保险经办机构依据评估结果直接向符合资质的护理机构购买相应的服务。

图表 29：15 个试点城市长期护理保险支付待遇对比

试点城市	补偿对象	支付方式	支付比例/金额
上海	失能评估二至六级	按比例补偿	• 居家护理 90%，机构护理 85%，住院医疗参照医保
安庆	Barthel 评定重度失能	按比例补偿	• 医疗机构护理 60%（上限 50 元/天），同时享受医保住院待遇 • 养老服务护理 50%（上限 40 元/天） • 上门护理限额 750 元/月 • 非协议机构护理补助 15 元/天
成都	重度失能人员	按比例补偿	• 居家护理 75%，机构护理 70%
广州	Barthel 评定不高于 40 分，或不高于 60 分且二级以上医疗机构诊断痴	按比例补偿	• 居家护理 90%（上限 115 元/天） • 机构护理 75%（上限 120 元/天） • 医疗护理按服务价格（上限 1,000 元/月）

试点城市	补偿对象	支付方式	支付比例/金额
	呆症		
长春	Barthe 不高于 40 分、《综合医院分级护理指导意见（试行）》一级护理条件、卡氏评分 KPS 不高于 50 分的癌症晚期患者	按比例补偿	• 养老或医疗机构护理：职工医保补偿 90%，居民医保补偿 80%
荆门	Barthel 评定低于 40 分	按比例补偿	• 居家护理：全日限额 100 元/天，基金支付 80%，非全日限额 40 元/天 •养老机构护理：床日限额 100 元/天，基金支付 75% • 医院护理：床日限额 150 元/天，基金支付 70%
南通	Barthel 评定重度失能	按比例补偿	• 定点医疗机构 60%，同时享受基本医保待遇 • 定点养老机构 50% • 定点机构上门照护限额 1,200 元/月
齐齐哈尔	Barthel 评定 40 分以下	定额支付	• 医养护理机构：30 元/天，基金支付 60% • 养老护理机构：25 元/天，基金支付 55% • 居家护理：20 元/天，基金支付 50%
青岛	Barthel 低于 60 分，2017 年纳入重度失智人员	定额包干结算	• 医疗护理：三级医院 210 元/天，二级医院 180 元/天，失智 65 元/天（日间 50 元/天） • 生活照料：评估三级 22 元/天，四级 35 元/天，五级（和重度失智）50 元/天，个人自负 10% • 居家照护：50 元/小时，个人自负 10%
上饶	重度失能、失智人员	定额支付	• 居家护理：450 元/月 • 居家上门护理：限额支付 900 元/月 • 机构护理：每月 1,080/月
八狮石河子	人社局劳动能力鉴定办评定失能等级为长期重度失能	费用补偿+定额支付	• 协议服务机构：70%，限额 750 元/月 非协议机构/居家：25 元/日，参保人员在住院期间享受护理保险待遇
苏州	中度失能或重度失能	定额支付	• 机构：重度失能 26 元/天，中度失能 20 元/天 • 居家：重度失能 30 元/天，中度失能 25 元/天
承德	Barthel 评定低于 40 分	定额支付	• 定点医疗机构护理：60 元/天 • 定点护理服务机构、养老服务机构：50 元/天
宁波	失能评估为重度失能	定额支付	• 医疗、养老机构护理：40 元/天 • 享受专护服务的，可同时在该医疗机构按规定享受基本医疗保险 住院待遇
来源：太保安联研报			

由蔡伟贤等的《长期护理保险、居民照护选择与代际支持》，长护险的实施

显著降低了代际转移支付[②]的发生数额，可以看出，长护险降低了失能家庭长期照护费用，从而减轻了子女照护父母的经济负担。

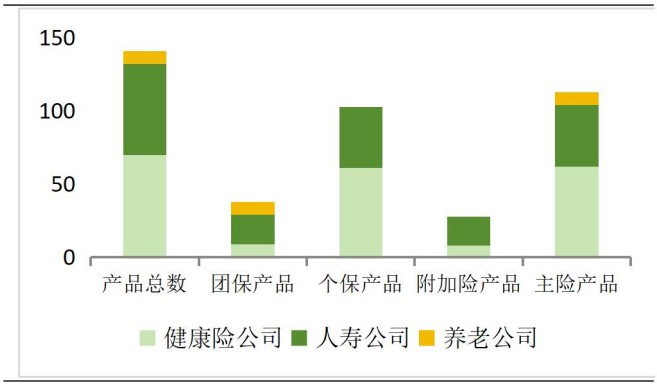
3.2.3.2. 商业护理保险

发展商业护理保险作为补充是未来的必然趋势。我国当前长护险对医保基金的依赖较大、筹资渠道过于单一，而商业保险的进入使得长期护理保险制度资金来源进一步多元化，有助于建立收支平衡的筹资给付模式，减轻我国财政压力。除此之外，商业保险发展多年，形成了专业化产业和团队，可以提供更安稳的风险管控方案和更优质的客户服务，分摊长期护理保险资金的风险，减少经营成本。商业保险公司积极投入市场后能够提供多种补充养老方案，方便参保者选择的同时也在领域内形成良性竞争，从而激发市场活力。

目前，市场上已经出现部分商业性的长期护理保险产品，但总体来看，**我国商业性长护险仍处于起步阶段，存在较多问题**。首先，已有产品的规模和数量较小，2022 年我国商业保险保费仅 306.62 亿元，占健康险比重 3.54%，2023 年 49 家国内保险公司在售的商业护理保险产品共 141 款，远低于健康险产品总数。其次，我国已有的保险形态单一、同质化严重，主要以保障疾病和意外伤害造成的失能风险为主，与疾病保险和意外伤害医疗保险保障功能重叠，而失智类保障产品缺乏，不能较好地满足市场需求。此外，我国已有商业护理保险产品限制条件较多，覆盖面有限。这些产品面对对象多是高收入人群，保费和支付金额较高，中低收入家庭难以承担；对投保年龄和续保年龄也有较大限制，大多需要在 60 岁以下。

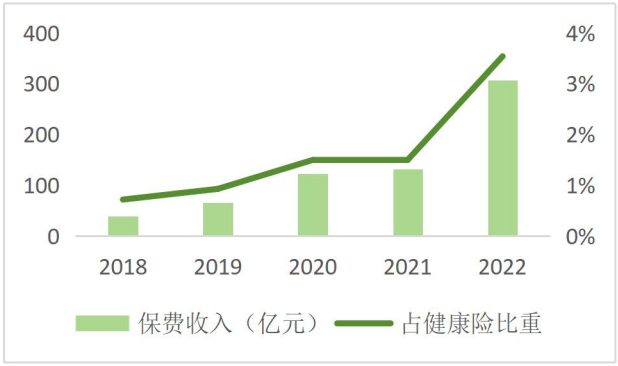
② 代际转移支付，在这里指当家中有失能老人时，子女对父母的单向代际转移支付。

图表 30：我国在售商业护理保险产品概览



来源：《我国商业护理保险发展问题研究》

图表 31：2018—2022 年我国商业护理保险保费情况



来源：《我国商业护理保险发展问题研究》

未来，我国应该制鼓励更多商业保险公司参与进入长期护理保险市场，推出多样化的商业长期护理保险，使老年人可以根据自己的失能程度和实际需求选择合适的商业险作为补充。

3.3. 中日对比，一窥未来商业模式

3.3.1. 运营模式

目前，中国居家养老的主要运营模式是**由政府主导，由企业雇佣专业人员上门提供助餐、助浴、助医、助洁、助急等服务**。这类专注居家养老的企业收入来源主要是通过护理员等专业人才提供的服务来获取相应服务费；而成本项主要是人员雇佣成本，也包括各类管理、培训成本和信息化投入成本等。受老年人支付能力和消费习惯等影响，目前大多企业主要通过为长护险试点和社区提供养老服务、与 G 端（政府部门）合作，间接覆盖 C 端老年客户。

日本养老服务的提供主体大致经历了从国家全面承担责任，向社会共同承担责任，再到居家服务为基础的模式。当下，日本的社会养老服务体系**由中央政府、地方政府、市场力量、居民互助组织以及公民个人的多方主体**共同参与。具体而言，中央政府负责养老服务的整体规划、法律制定、资金筹集与监督管理，同时承担兜底性救助服务；地方政府作为中央政府的执行者，负责具体落实相关政策和措施，基于地方的财政水平与老年群体的实际需求，自主开展服务项目；民营机构通过政府的定向委托和公开招标积极参与到养老服务的供给。此外，活跃于

社区的居民互助型社会组织也为社区老年人提供多元化居家养老服务。受益于介护保险，日本老年人仅需支付技能训练及康复训练介护费用的 10%，剩余 90%均由保险承担。

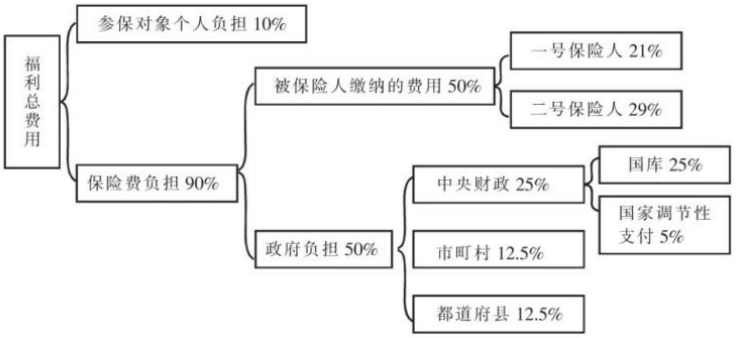
居家养老是一个复杂多样的问题，未来**建立多元主体体系**是解决养老问题的必然举措。我国应完善居家养老的协同治理体系，打通多元主体之间的合作，让政府、医院、社区、企业、公民都积极参与到居家养老的服务中来。

3.3.2. 长护险制度

法律保障方面，我国面向失能老人的养老服务相关政策碎片化现象严重，整体协同度不高，缺乏面向失能老人服务的整体规划、专门政策和制度引导；也缺乏税收、金融和土地等相关配套政策。日本早于 1997 年颁布《护理保险法》，因此在 2000 年介护保险正式实施之前，日本已有良好的制度运行基础；而在介护险正式实施时，日本对于否缴纳保金额度、可得到的护理项目、护理机构运营标准和服务人员水平等都在法律中作出了清晰规定，避免了因无法界定导致的混乱局面。

资金来源方面，我国目前的筹资方式过于依赖医保基金结余和政府的财政补贴，长此以往会导致长护险基金不能承担风险或是政府加大补贴带来巨大财政压力。而日本采取政府主导、服务机构辅助、多渠道并行的筹资模式，确保了养老服务的稳定性和可持续性。

图表 32：日本介护保险制度保费构成

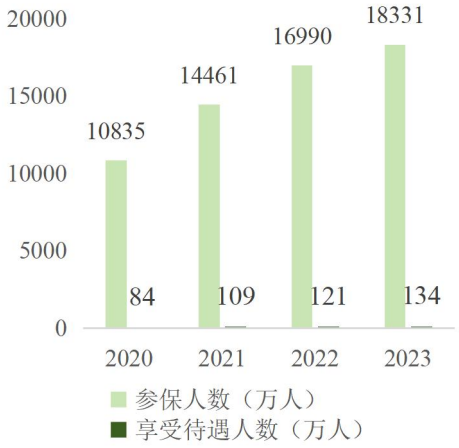


来源：《日本介护保险制度对健全我国失能老人照护体系的启示》

保障范围方面，和日本相比，我国长护险制度尚处于起步阶段。全国试点城

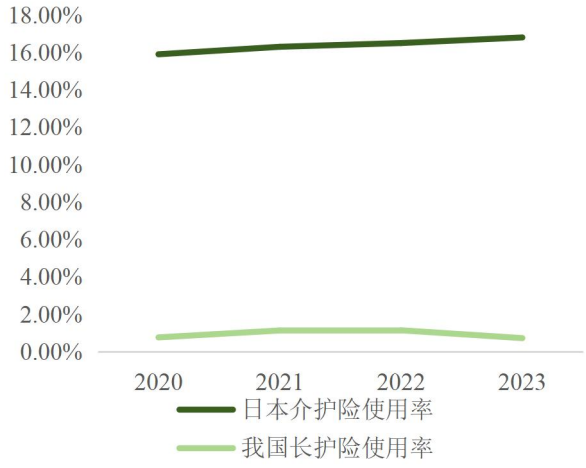
市中，大部分试点城市仅将重度失能人员作为保障对象；而日本凡是年龄达到 40 岁以上的日本国民即为参保对象。截至 2023 年，我国试点地区的长护险参保人数达到 18330.87 万人，享受待遇人数 134.29 万人，长护险使用率为 0.73%，远低于同年日本长护险使用率 16.83%。

图表 33：我国长护险享受待遇人数较低（2020—2023）



来源：中国消费者协会

图表 34：中日长护险使用率对比（2020—2023）



来源：国家医疗保障局，日本厚生劳动省

评估标准方面，我国大多数试点城市直接采用《日常生活能力评定量表》，依据分值判定是否给付护理服务，但从实施效果看，存在评定内容过于简单、形式过于单一等问题，可能会将部分失能者排除在外。同时，评定方法以问卷形式为主，具有一定的主观性。

4. 微观分析

我国居家养老服务机构**市场较为分散，以初创型企业为主**，代表性企业有福寿康、小橙集团、颐家养老、璞缘照护等，其中**福寿康**是全国连锁化、品牌化的综合性养老照护服务机构，也已成为全国规模最大的居家医疗照护服务机构之一，竞争力较强。下文将聚焦行业头部企业福寿康，分析其发展现状，并结合国内外企业发展经验，思考其优化路径。

4.1. 福寿康发展现状分析

4.1.1. 福寿康简介

福寿康智慧医疗养老服务（上海）有限公司（下称“福寿康”）2011 年成立于上海，以“打造中国居家医疗照护领导品牌”为愿景，致力于为客户提供专业、优质、便捷、放心的社区居家医疗、护理和康复服务。福寿康在社区居家养老领域精耕细作十余载，是目前我国规模居前的居家医疗照护服务机构。

福寿康 2017 年成为上海市首批长护险试点机构，2018 年开始实施全国拓展战略，年服务量快速增长并实现整体收入过亿；2019 年整体收入超过 6 个亿；福寿康着力推动长护业务与商业业务“双轮驱动”，其收入中长护险约占 60%以上、民政购买服务约占 15%、市场化个人付费约占 25%。截至 2023 年底，福寿康业务在全国布局超过 60 个城市，其中有 40 多个城市开展了长护险业务；在全国范围内运营 400 余家分支机构，包括 8 家护理培训学校、10 家养老院、70 余家日间照料中心及长者照护之家、1 家互联网医院、13 家诊所、260 多家护理站等，并设有 280 多个长护险定点护理站；员工超过 1 万人，累计服务用户约 25 万人，年服务量超过 1800 万人次。

图表 35：福寿康发展历程

年份	发展历程
2011	福寿康成立，中国居家养老行业早期探索者
2013	纳入政府指定的居家医疗护理服务商名录
2015	上海首批高龄老人医疗护理保障计划试点机构
2016	建立“医疗护理站+社区托养机构”服务模式，获天使轮投资
2017	成为上海市首批长护险试点机构
2018	实施全国拓展战略，获 A 轮融资
2019	确定“互联网+医护康养”发展模式
2020	全国布局城市超过 30 个，获 B 轮融资
2021	全国布局城市超过 50 个，获 B+轮融资
2022	全国分支机构突破 400 家，获 C、C+轮融资
2023	长护与商业“双轮驱动”，布局城市超 60 个

来源：福寿康官网

图表 36：福寿康年服务量持续增长

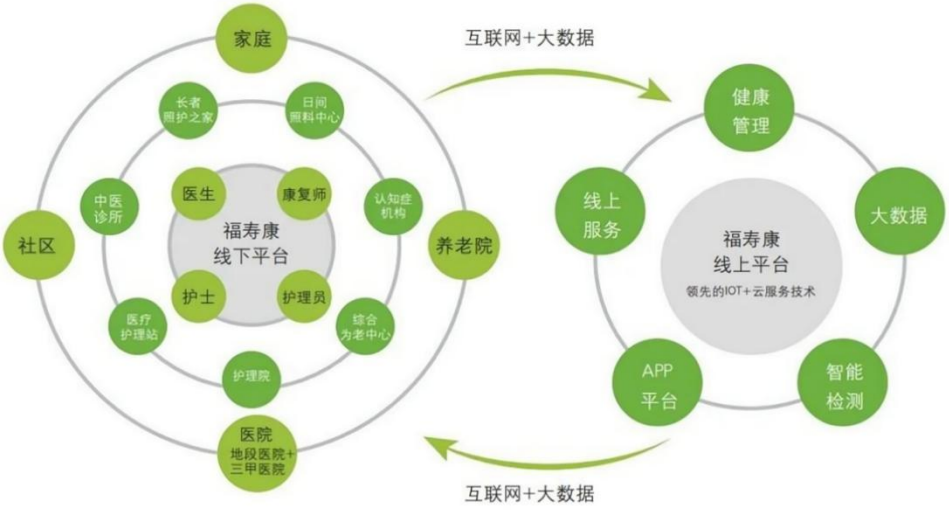


来源：福寿康官网

4.1.2. 福寿康业务开展情况

福寿康开创“医疗护理站+日托”“医疗护理站+长者照护之家”模式，既能服务社区托养机构，又能以托养机构为站点辐射周边社区，实现医养整合照护模式。2019 年，福寿康确定“互联网+医护康养”的整合式养老照护服务模式，完善服务网络，打通居家、社区、医院、养老机构的全链条服务场景，为健全自理老人、失能/半失能老人、失智/半失智老人、疾病期老人等人群提供一站式综合服务。

图表 37：福寿康“医护康养”生态圈



来源：平安证券

具体而言，福寿康主要提供以下五个方面的服务：

1）长期护理：根据上海长护险试点规定，福寿康面向参加本市职工医保和城乡居民医保 60 岁以上的人员，按照不同评估等级每周提供不同频次的上门服务，服务内容包括 27 项基本生活照料和 15 项常用临床护理。服务费用由长护险基金支付 90%、个人支付 10%，其中护理员上门提供基本生活照料需自付 6.5 元/小时、护士上门提供常用临床护理需自付 8 元/小时。

2）日式助浴：为失能或半失能、术后、临终客户提供上门洗浴服务，保持身体清洁，促进血液循环，提高生活质量，维护客户尊严。服务内容包括测量血糖血压、呼吸脉搏等生命体征；清洗身体、洗头、洗面；修剪指甲、剃须、理发等。

3）私人专护：为失能、半失能、失智、疾病期、临终期客户提供医院陪护和居家照护服务，包括协助/专业/专项/特需护理等。

4）康复指导：康复护理师根据客户个体情况，结合物理疗法（PT）、作业疗法（OT）、言语疗法（ST）、中医疗法以及心理疗法，最大限度恢复客户的残存肢体机能，提高其生活自主能力，提升生活质量。康复指导适用于脑血管及脑损伤康复、骨折及骨关节病康复、术后恢复和认知功能康复等情况，服务费用按照康复计划定制报价，专业康复师 250 元/小时。

5）认知症照护：为认知症长者提供专业的认知症评估、一对一照护计划、BPSD 周边症状应对等认知症专项服务，以及中医保健等康复训练服务和基本生活照护服务等。

图表 38：福寿康“照护 365”小程序界面



来源：福寿康“照护 365”小程序

此外，福寿康积极**投入信息化平台建设，开创智慧养老新模式**，树立智慧养老新标杆。2017 年底，福寿康公司成立 IT 部门，组建技术团队，加大力度投入《福寿康居家康复护理服务管理平台》建设，深入了解客户需求，监控服务数据与质量。2018 年 10 月，《福寿康居家康复护理服务管理平台》获上海市服务业发展引导资金数百万的支持，人事管理系统、客户管理系统、长护险业务系统、工单系统、太平洋长照系统、居家床单元系统、长者综合能力评估系统、福寿康大数据平台等功能模块正式投入使用，客户达 48000 人，日处理工单 20000 余条，

服务器日平均请求量达 20 万次。

4.1.3. 主要企业对比分析

居家养老服务行业尚处发展早期，各企业纷纷探索商业模式，创新服务形式，以期把握市场风向，满足银发群体对居家养老服务不断增长的需求。下文从成立背景、规模、融资情况、服务模式、收入情况等方面对福寿康、小橙集团、颐家养老、璞缘照护四家居家养老服务提供商进行了对比分析，并总结了各企业发展特点，以呈现当前行业实践、明晰福寿康竞争格局。

图表 39：代表性企业发展情况对比

	福寿康	小橙集团	颐家养老	璞缘照护
成立背景	2011 年，上海	2018 年，天津	2013 年，上海	2017 年，上海
简介	福寿康推进“互联网+医护康养”整合照护模式，打通居家、社区、医院、养老机构的全链条服务场景，为失能失智长者提供涵盖长期照护服务、机构照护、居家照护、智慧家床、住院陪护、院后康复、中医治疗、上门助浴、辅具租赁、适老产品在内的一站式综合服务。	小橙集团依托数字化医养平台，整合智能养老产品与综合养老服务，提供生活照料、医疗护理、病患管理、康复理疗、辅具租赁、适老化改造、护理员培训等一站式数字医护康养解决方案。旗下设有小橙长护、康力元、小橙科技与小橙数字等多个品牌，全面构建综合为老服务生态。	颐家是一家专业提供医疗级服务的医养照护服务机构，拥有颐护到家、颐家诺、颐护直达等多种模式，为社区老人提供医、护、康、养、险服务，形成特色的“医养服务平台网络”，实现“全人、全龄、全家、全程”照护服务。	璞缘照护拥有六年长护居家服务经验，五年社区日照运营经验，业务网点从长三角出发已遍布全国，致力于发展居家养老长期照护、术后陪护、康复护理、慢病照护、失智老人照顾、智能养老生活、社区日照运营等服务模式。
规模	全国布局城市 60+，分支结构 400+，人员 10000+，年服务量 1800 万+，服务对象约 25 万。	全国布局城市 30+，线下服务站点 100+，人员 15000+，累计服务 410 万+。	全国布局城市 40+，线下服务站点 100+，人员 30000+，年服务量 800 万+。	全国布局城市 30+，人员 3000+，年服务量 350 万+，服务对象 1.5 万+。
最新融资	2022.12，C+轮，1 亿元。	2023.12，战略投资，1000 万。	2023.12，B 轮，数千万元。	2023.3，A 轮，数千万元。
服务模式	①以居家照护为核心，“互联网+医护康养”整合照护，线上、线下平台相融合； ②“医疗护理站+社区照护中心+养老院”服务网络体系； ③标准化服务流程。	①“产品+服务+信息化”生态模式，聚焦长护险重点试点城市； ②现已开发出家庭陪护机器人 1.0 版本； ③逐步探索社区站点、养老服务综合体模式； ④标准化服务流程。	①专业运营服务商：利用大数据、人工智能、语音识别等高新技术，构建以康养服务和家庭健康管理为中心的一体化服务解决方案（PACE）； ②社区及居家医护康养服务； ③个性化解决方案，标准化服务。	①承担长护险业务的同时，探索社区养老服务的承接； ②未来探索线上与线下养老服务的融合发展模式，进一步丰富服务类型，探索多元化商业助浴服务与临终关怀、康复训练入户等养老增值服务； ③标准化服务流程。
收入情况	①长护险服务（60%），自费比例 10%，医保统筹	①长护险服务； ②商业护理险服务；	①长护险服务； ②商业自费业务	①长护险服务，医保报销 90%，个人承担 10%；

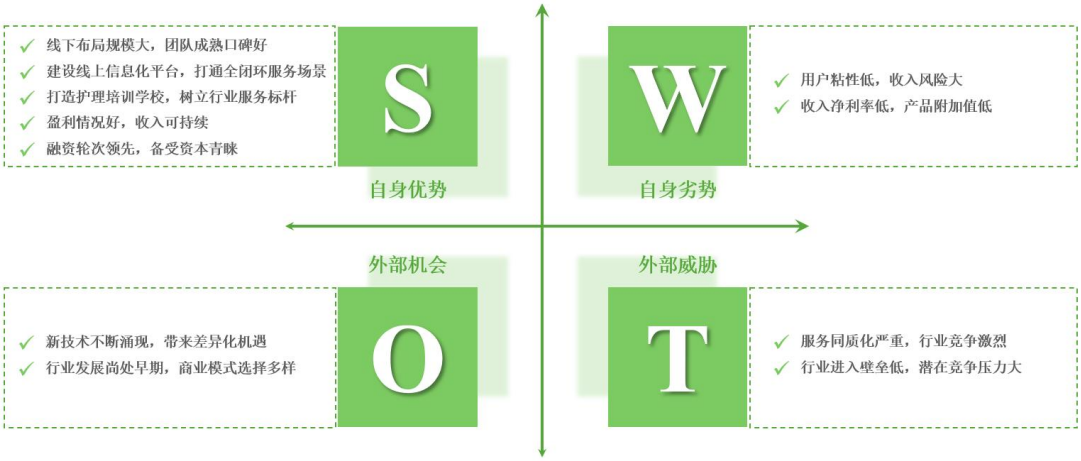
	支付比例 90%； ②民政购买服务（15%）； ③市场化个人付费（25%）； ④已实现 4 年盈利，总营业额逾 6 亿元，净利润 7%。	③适老化改造； ④康复辅具产品； ⑤居家养老智能化产品； ⑥信息化系统； ⑦2022 年营收约 2 亿元。	（PACE）； ③商业保险服务； ④社区养老、护理站； ⑤智能康养平台； ⑥2023 年营收同比增长 80%，有望突破 10 亿元。	②社区养老服务； ③2022 年体量增长 60%；2023 年实现正向盈利，较 2022 年营收翻倍。
特点	①原“上海市高龄老人医疗护理计划”“长期护理保险”首批定点服务机构，布局早、规模大，团队成熟； ②自主研发社区养老服务交互系统，打通居家、社区、医院、养老院的全闭环服务场景； ③自主设立护理培训学校； ④获众多顶级投资机构投资。	①依靠康力元护理辅具的销售进行客户转化； ②通过信息化手段，全面构建服务运营体系、管理体系、监察体系、回访体系，实现流程标准化和运营高效化； ③提供护理人员培训服务； ④提供更全面的生态，打造生态闭环，包括产品、数字化、医疗、保险等板块。	①自研“服务过程数智化监管系统 AHC”（运用技术对居家服务过程进行全景还原）、I-CARE 智能康复照护平台（整体交付标准化、可视化）、颐护小友 Care Mate（护理 AI，赋能服务人员，提升服务技能）； ②提供护理人员培训。	①提倡“两尊一敬”，尊敬老者与照护人员，敬畏专业； ②创始人曾任世界 500 强连锁企业副总裁，核心团队在连锁机构管理方面积累了深厚经验，推行完善的照护服务 SOP 流程； ③自成立以来发展迅速。
来源：公司官网，公司官方微信公众号，长生不老小组整理				

由对比可知，四家企业提供的居家养老照护服务都主要集中于生活照料、院后康复、医疗护理等方面，并以长护险服务为主要业务来源；均以居家照护为核心，逐渐拓展至“居家+社区+机构”的综合服务模式；均尝试建立信息化平台以提高服务质量、管理效率。其中福寿康、颐家养老、璞缘照护目前均呈现“横向发展”，即聚焦护理行业，寻求规模化拓展；小橙集团则尝试“纵向延伸”，探索深度闭环的生态模式。此外，福寿康把握先发优势，注重品牌、服务团队建设；颐家养老积极将大数据、人工智能等新技术融入企业管理平台。

4.1.4. 福寿康 SWOT 分析

结合行业背景与竞争格局，可对福寿康进行如下 SWOT 分析：

图表 40：福寿康 SWOT 分析图示



来源：长生不老小组整理

4.1.4.1. 自身优势（Strengths）

1）线下布局规模大，团队成熟口碑好。福寿康早期以长护险服务为重要抓手，已成功跑通上海居家上门综合照护服务模式，对长期护理的受益对象、申请、评估、服务内容、自费价格都有详细的规定。随着长护险试点的铺开，福寿康迅速在全国范围内取得布局拓展、服务口碑。在线下，福寿康在全国 60 多个城市布局 400 多个分支机构，年服务量达到 1800 万次以上，累计服务约 25 万用户，构建了庞大的线下服务网络，远超另外三家企业，具有较为明显的先发优势。同时，福寿康作为中国居家医疗照护的领导品牌，经过 13 年耕耘，已形成了一套自有的、完善的、精细化专业服务体系，外加训练有素、经验丰富的专业的医疗照护人员队伍，能较好地解决传统居家养老模式中养老服务内容单一、服务水平参差不齐的弊病，不断满足人们养老消费升级换代的需要和对高质量、高水平服务的期待，曾荣膺“2021 科技养老创新企业 TOP10”，在市场中有良好的品牌口碑。

图表 41：福寿康全国布局图



来源：福寿康官网

图表 42：颐家养老全国布局图



来源：颐家养老官网

图表 43：璞缘照护全国布局图



来源：璞缘照护微信公众号

图表 44：小橙集团全国布局图



来源：小橙集团微信公众号

2）建设线上信息化平台，打通全闭环服务场景。福寿康依托多年居家养老服务实践经验、海量自有客户、广泛覆盖的服务站点、丰富的社区医疗资源、居家健康管理系统，自主研发了养老信息交互系统，打通了居家、社区、医院、养老院的全闭环服务场景，在实践层面实现了“站点互通+服务互联+资源共享+平台共建”，成效显著。在线上交互系统，福寿康有效对接用户需求，实现智能派单、实时跟单；搭建基于老人群体的全方位健康数据中台，结合智能设备、照护管理 CRM 及智能化培训体系，深度响应和挖掘老人需求，为老人提供优质、便捷的一站式医护康养服务；搭建内部信息化管理平台，以实现对全国 400 多个连锁点位市场、运营、品控、培训、财务、人力等的规范化管理等。

3）打造护理培训学校，树立行业服务标杆。我国护理人员缺口高达千万，大多数养老护理人员专业化程度不高，且市场缺乏完善而专业的养老服务人才培养机制。对此，小橙集团、颐家养老等企业多提供岗前护理培训，而福寿康在此

基础上还进一步建立了 8 家护理培训学校，拥有线下护理职业技能培训基地以及线上教学系统，并于 2022 年获得养老护理员（三级/高级）职业技能等级培训资质。就业培训由集团统一系统化管理，全国培训基地采用统一的标准和教材，培训不仅为福寿康体系内部、也为社会养老机构和同行输送人才。这使得福寿康在一定程度上把握了养老服务行业上游人才供给的议价权，通过不断标准化人才培养来提高行业实现规模经济的可能性。

4）盈利情况好，收入可持续。至 2020 年，福寿康已实现连续 4 年盈利，收入规模超 6 亿元，收入体量较其他企业更大，盈利稳定。此外，除去由政府主导定价的长护险业务以及政府购买业务，福寿康有 25%的收入来源于市场化个人付费，且该部分收入占比较 2020 年增加了 10 个百分点。福寿康在市场化个人付费业务收入占比的上升表明，福寿康借助长护险引流，针对老人综合照护需求，在全天陪护、上门助浴、辅具租赁、适老化改造等 50 多项个性化商业增值服务方面有了较好发展，增强了其盈利能力及收入可持续性。

5）融资轮次领先，备受资本青睐。自成立以来，福寿康已历经七轮投融资，投资轮次处于领先位置，投资金额高达亿元以上，2022 年 8 月 C 轮融资后估值 15 亿元；更有红杉资本、腾讯投资、启明创投等明星资本的参与，其中腾讯为战略投资。充足的资金支持有利于福寿康进一步拓展、升级业务，诸如腾讯等互联网企业的战略投资也有助于福寿康借力信息化技术不断完善自身数字化平台构建，增强面向数智时代的竞争力。

4.1.4.2. 自身劣势（Weaknesses）

1）用户粘性低，收入风险大。养老服务行业发展早期，缺乏“介护险”对养老（增值）服务进行补贴、保障，没有养老机构发展的资质保障、社区场景，行业发展缓慢。对于养老照护服务，顾客更多是短期或单次购买，持续支付意愿不高，服务变现的延续性不高，让客户对专业照护、康复护理建立认知和消费意愿也是艰难的市场教育过程。“长护险”的出现，引入医保解决了支付问题，官方评估相关机构的服务质量解决了企业身份和性质问题，一定程度上促使居家养老服务成为了刚需。依靠长护险政策，福寿康可以不断扩张规模，实现稳定盈利，但一旦长护险筹资方面受到影响（如财政、医保支出减少）或者长护险政策发生变化（如医保统筹支付比例、补贴范围发生调整），福寿康近 75%（长护险+民

政购买）的收入也将发生较大波动，风险敞口较大。福寿康想要实现长期持续经营，需要在时间、空间尺度上不断平衡好“政府付费”和“市场付费”结构，平衡好短期利益与长期利益，密切关注政策发展趋势，勇于进行战略性调整，尝试商业化改造。

2）收入净利率低，产品附加值低。当前，福寿康净利率在 7%左右的较低水平，可能源于长护险对服务内容、自费价格等做出的限定限制了定点机构的加价空间，而福寿康主要收入来源于长护险业务；以及福寿康目前提供的护理服务大部分较为基础、简单，附加值低。这种净利率低、产品附加值低的状态使得福寿康总收入增长依赖于业务规模扩张，难以通过提高客单价毛利实现，而规模扩张又需要进一步的资本投入，这可能使得福寿康实现增长难度大、提升增速难度大。

4.1.4.3. 外部机会（Opportunities）

1）新技术不断涌现，带来差异化机遇。居家养老照护服务行业是一个以服务为重、人数众多的行业，市场的规模化与产业化离不开对新的信息化技术的学习与运用。大数据、人工智能的发展为养老服务行业带来了前所未有的冲击，也带来了差异化竞争的机遇：AI 技术解决方案、护理机器人、人工智能协同作业等的开发有助于提升服务质量、提高服务效率；基于大数据等技术的信息化管理平台、客户终端平台等的建设，可以使服务更加有序、透明。福寿康需要跟上时代步伐，跳出传统养老服务思维模式，综合运用新技术，不断刷新对客户（老人和子女）的认知，开发新的产品与服务，不断优化成本，提高服务效能。

2）行业发展尚处早期，商业模式选择多样。目前，居家养老服务企业进一步发展有众多路径，常见模式主要有两种：一是进一步丰富产品线，形成结构化的产品策略，拓展护理院、护理型养老机构、康复医院等重量级项目，以及养老护理外包、家政服务、医院陪护等轻量级成熟行业，不断完善从医院到家庭、从家庭到社区的产业链闭环；二是深度闭环生态模式，即以居家护理为中心，不断延伸发展硬件产品、数字化、医疗、保险等板块。据小橙集团董事长刘峰，浮于表面的服务可能会产生严重内卷，企业仅靠单一的服务很难长期良性发展，小橙长护更关注的“产品+服务+信息化”闭环发展模式。目前来看，福寿康的发展模式偏向上述第一种，聚焦“护理”垂类“跑马圈地”，形成品牌效应，也为生

态建设留出了空间。目前，行业发展尚处早期，各种商业模式能否获得长足发展，仍需各企业在实践中不断探索、检验，寻找适合的商业模式和市场定位，这不仅是一种挑战，更是无限的机遇。

4.1.4.4. 外部威胁（Threats）

1）服务同质化严重，行业竞争激烈。当前，长护险业务是居家养老照护行业中各企业的主要收入来源，长护险严格规定了受益对象、申请流程、评估等级、服务内容、自费价格等，各家企业提供的照护服务差异化较小，且价格可能相近，可视为高度同质化产品。这种情况下，福寿康主要业务难以在兼顾成本的基础上形成差异化亮点，培育用户粘性难度较大，竞争压力较大。随着长护险政策的不断普及、养老服务行业的不断发展，类似企业将不断涌现，加剧行业竞争。

2）行业进入壁垒低，潜在竞争压力大。居家养老照护行业属于轻资产行业，主要成本来源于护理人员，养老服务生态链上其他企业（如提供适老化改造、居家养老智能化产品、养老金融等服务的企业）可以轻松借助原有业务基础、招收护理人员，进入居家养老服务市场，并利用原有客户迅速扩大影响力，对福寿康等以“护理”起家的在位企业造成了巨大威胁。例如，中国平安成立居家养老项目组，提供“保险+居家养老”服务，截至 2024 年 6 月已覆盖全国 64 个城市，累计超 12 万名客户获得服务资格、超 6 万名客户开启服务。以保险服务带动居家养老照护服务布局，以居家养老照护服务促进寿险主业发展，中国平安实现了生态链上业务的相互赋能。

4.2. 美国居家照护服务个案研究

2023 年美国养老服务市场价值为 4554.9 亿美元，复合年增长率为 6.15%。婴儿潮一代的增加、老龄化人口的增加、医疗支出的增加以及对独立生活的偏好增加等共同促使美国养老服务市场竞争激烈，美国居家照护服务提供商 Amedisys 是其中的佼佼者，下文将通过分析 Amedisys 公司的情况，展现发达国家体系下的老年居家照护服务的布局现状和发展趋势，从而为国内计划在居家照护服务领域发展的企业提供经验借鉴。

4.2.1. Amedisys 公司简介

Amedisys 公司成立于 1982 年，是**美国最大的家庭医疗护理服务提供商和第二大临终关怀提供商**，致力于将无微不至的、个性化的健康护理服务带入家庭。截至 2021 年年底，Amedisys 业务范围覆盖美国的 38 个州、528 个护理中心，每年为 44.5 万名患者提供超过 1150 万次就诊，和全国超过 3000 家医院和 10 万名医生有急性期后护理的合作。

4.2.2. Amedysis 公司业务

Amedisys 的客户群体涵盖各种年龄段和健康状况的患者，大部分客户为 80 至 84 岁的老年人，这一群体的慢性病患者从急性、短期疾病逐渐转变为长期、慢性病，护理需求持续增加。Amedisys 为客户提供三个板块的业务：**家庭医疗、临终关怀、高敏感护理。**家庭健康服务，提供包括熟练护理、治疗服务及日常生活活动协助在内的多种支持。临终关怀服务，提供全面的医疗、疼痛管理、情感支持和精神指导，旨在为绝症患者提供安慰和支持，提升患者及其家属的尊严和生活质量。在高敏感护理领域，Amedisys 与全国性和大型医疗保健系统合作，提供住院级居家护理。

4.2.3. Amedysis 公司商业模式

Amedisys 公司最初提供基本护理服务，逐步扩展到家庭健康护理和临终关怀护理业务，通过采取连锁经营的方式进行扩张，同时积极推进与全国各地医疗机构的合作，Amedisys 以最高效的方式占领地方市场，逐步形成了“家庭+养老院”模式，构建了一种便捷且可持续的医疗服务模式。通过深入分析 Amedisys 的商业模式，可以识别出其在运营效率、服务质量和客户体验等方面的关键要素，从而为福寿康制定有效的发展战略和市场应对措施提供指导。

1）**专业团队：全面支持，服务个性化。**Amedisys 的专业护理团队是其核心竞争优势之一，包含经验丰富的护士、物理治疗师、职业治疗师、社会工作者和临终关怀专家等，这些医护人员经过严格的专业培训，能够提供全面、个性化的医疗护理和心理支持。护士和治疗师为患者提供包括伤口护理、药物管理和康复治疗在内的服务；社会工作者和心理支持专家则帮助患者及其家属应对治疗过程

中的心理和情感挑战。这种高度协同、患者为中心的团队模式，保障了 Amedisys 的服务质量，巩固了其在居家护理行业的领先地位。

2）**创新技术：技术迭代，管理信息化。**Amedisys 通过技术整合开发了智能护理管理系统，优化了上门服务的流程，使护理团队可以迅速了解患者的最新健康状况并调整治疗方案，增强了与医疗服务提供商和支付方的合作关系。公司通过与其他公司展开合作引入了分子检测技术，不仅提高了诊断的准确性，还显著降低了整体治疗成本。

3）**并购合作：战略并购，合作多元化。**Amedisys 在过去的几年里，成功地通过并购策略增强了自身的市场地位。例如在疫情期间，Amedisys 采用中型区域性并购策略，收购了“医院到家”服务提供商 Contessa Health（"Contessa"），从而建立高危护理部门。此外，Amedisys 与医院、医疗机构、医疗保险公司、社区服务机构等多类型机构建立了密切的战略合作关系，搭建全面、精细、无缝衔接的服务体系，不仅提高了患者的满意度，也为公司节省了运营成本。

4）**盈利模式：依托机构，多渠道盈利。**Amedisys 与 Medicare 和 Medicaid 等政府机构以及私人保险公司签订合同，为符合条件的患者提供临终关怀服务和居家照护服务，根据按服务收费的模式获得护理的报销，从而为向患者提供的特定服务计费。Amedisys 在与医保等支付方谈判时，得益于其庞大的规模与出众的议价能力，能够获得更有利的报销条件，从而确保收入稳定。

5）规模效应：多点连线，业务铺排广。一方面，Amedisys 通过在 34 个州设立了 346 个家庭护理中心和 165 个临终关怀中心，实现业务的大规模覆盖，使得公司能够分摊固定成本。另一方面 Amedisys 实施标准化的培训和管理流程，通过集中培训和共享最佳实践，快速提高员工的专业能力和服务水平。大规模的服务网络使得资源配置更加灵活，能够在需求波动时快速调整，同时也使得 Amedisys 在与供应商合作时具备更强的议价能力，能够以较低的成本获取医疗设备、药品和其他护理所需材料。

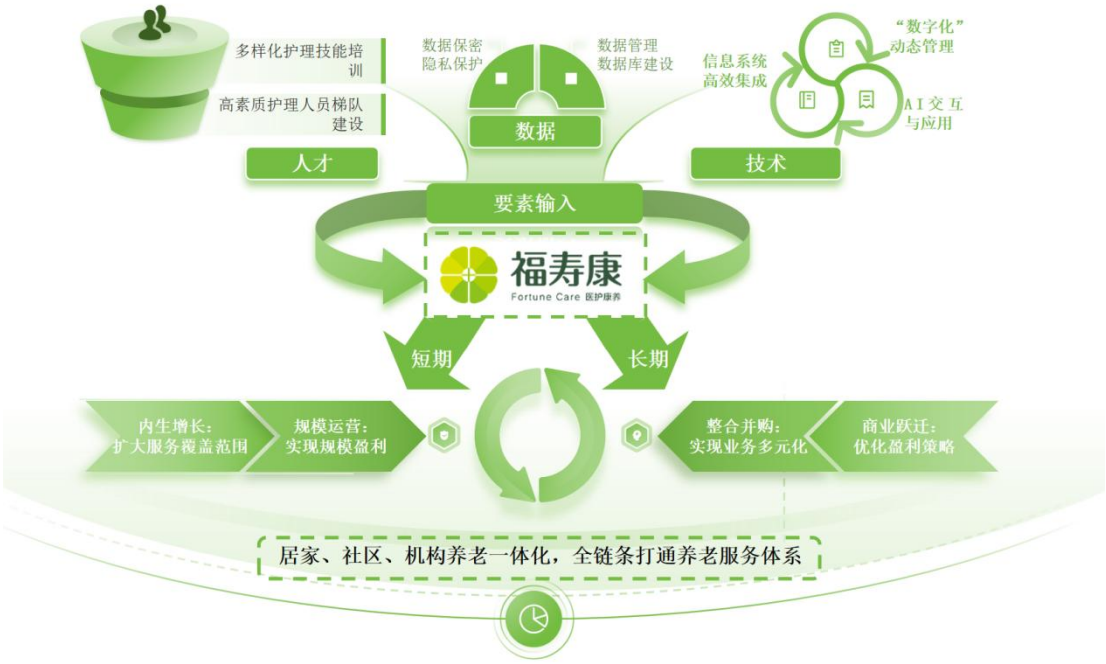
6）政策响应：审时度势，政策响应快。Amedisys 积极响应医保政策的变化，如 CMS 推出的家庭健康价值采购模型（HHVBP）和患者驱动分组模型（PDGM），确保在行业整合过程中保持竞争优势。通过有效应对 HHVBP 模型，Amedisys 可以改善患者健康结果，获得更高的绩效分数，从而获得更多的经济激励。成功

整合 PDGM 使其能够提供更个性化的护理，减少不必要的治疗费用，并保持盈利能力。这些调整确保公司在监管变化中保持灵活性，有助于其在竞争激烈且不断变化的医疗行业中实现长期增长和稳定。

4.3. 福寿康发展战略

医疗保健行业的领先机构并不满足于简单地在有吸引力的细分市场和市场中发挥作用，而是主动并从根本上重塑行业的运作方式和护理的提供方式。虽然各个垂直领域的做法各不相同，但新商业模式的共同点是激励措施的更大一致性，通常涉及风险承担、高效协同、关键资源壁垒强化以及数据和技术手段运用。基于此，结合对于福寿康公司本身发展特点以及对 Amedisys 公司商业模式与发展亮点的分析，可以对于福寿康未来的战略规划提出以下建议。福寿康的整体战略应定位于通过积累优质的人才、数据与技术要素，短期内实现内生增长扩大业务覆盖范围，长期内坚持通过并购与合作扩展商业布局，实现业务多地区、全类型覆盖，从而满足大规模客户的多元化需求，最终搭建起全链条养老体系，全面提升其在养老服务市场中的竞争力和覆盖率。

图表 45：福寿康发展战略示意图



来源：长生不老小组整理

4.3.1. 要素投入：人才优化与技术迭代双措并举

1）人才优化：引育留用，壮大人才队伍

目前福寿康已经建成护理培训学校、护理技能培训基地以及线上教学系统，形成了完善的人才培养和输送体系，处于人才供给的有利地位。随着社会发展和人民生活水平的提高，除基本的专业护理技能外，老年人也渴望更全面的情感和心理支持，凸显引入具有心理专业背景的复合性人才的必要性。与此同时，当前护理服务市场整体人员队伍普遍存在年龄大、学历低的问题，高素质、高能力的护工普遍缺乏。福寿康不仅要继续扩大培训中心和基地的覆盖范围，也要兼顾培训质量、持续优化培训体系，产出足够数量的高素质护理人才以回应日益上涨的养老服务需求，形成多层次的护理团队。

随着人才队伍的建设日趋完善，福寿康同时需要考虑留住人才、用好人才的问题。具有丰富的居家养老照护服务行业专业能力和管理资源的从业者属于行业中稀缺但关键的资源，福寿康需要“软硬兼施”，一方面提供硬性的薪酬激励，打通职业上升通道，一方面提供良好的组织文化氛围和福利，赋予居家养老照护服务本身更多价值，让人才与公司形成良好的适配，进一步强化公司的业务优势。

2）数据管理：保护隐私，规范数据管理

互联网时代，数据资产已经成为第四种生产要素，是数字经济中的基础性资源和战略性资源。福寿康作为提供居家养老照护服务的平台型企业，业务运作过程涉及对客户数据的采集和追踪，此时需要注意确保客户隐私的保密性，尊重个人隐私和相关法律规定。在对采集到的客户数据进行脱敏等操作后，福寿康可以在征得客户及其家属同意的情况下，对数据进行描述性统计、归类和深度分析。目前与人工智能交联并深度融合是各个行业的普遍趋势，福寿康如若能提前布局居家照护服务数据库的建设，将利好其掌握优质的养老照护服务数据资源，并将其接入人工智能大模型，甚至进一步建设养老照护服务领域的专用大模型，

3）技术迭代：AI 赋能，打造智慧平台

福寿康应及时跟进技术前沿，持续开发并更新信息管理系统、运营调度系统等公司内外部管理的技术系统，从而把控服务质量、提高顾客满意度。目前养老照护设备提供商诸如北京万科和图灵看护已经将人工智能整合进入端侧设备，这对于养老服务提供商也是机会，能够更好地与智能端侧设备形成连续价值链的服

务平台将有望实现更为显著的协同效应。福寿康应该循序渐进将大数据、人工智能等新兴技术引入信息化平台建设和养老护理服务，不断提高管理和服务效率。例如，利用 AI 技术分析老年人的健康数据，提前预警潜在的健康问题，并为护理人员调整照护方案提供决策支持；鼓励护理人员与 AI 协同工作，利用 AI 提供实时的知识库和指导、提供老年人的行为预测，从而精准提供护理服务；利用 AI 分析历史服务数据和当前需求，构建模型优化人力和物力资源配置，确保在需求高峰时期能及时、恰当地响应。

4.3.2. 短期战略：内生增长，快速规模化

目前，福寿康以**“跟随长护险政策”**为主导布局策略，在长三角和珠三角取得了稳健发展。下一步福寿康可以采取**“直营”+“加盟”**的双模运营模式：持续以直营模式作为收入贡献的主力，建立成熟的单店模型和标准化运营体系，确保新店能够快速复制成功经验，分层管理减少培育周期、提高扩张效率；同时利用加盟模式整合资源孵化市场，快速拓展业务，不仅可以保持品牌的统一性和服务质量，还能迅速扩大市场覆盖范围。未来，随着北部和西北部市场的开拓，福寿康可以借鉴“阿米巴经营模式”，自上而下进行量化分权，赋予每个站点更大的经营自主权和灵活性，综合评估特定站点政策推动节奏、当地养老需求和文化特点，实现“标准化与一城一策”并重的策略，增强适应性和员工的服务积极性。

福寿康通过直营店模式能提高门店的运营效率、安全性及盈利能力，并充分控制服务的质量。门店网络依靠全面标准化确保服务质量及客户体验一致性，在全国有望实现快速复制。加盟模式则需要保证使用相同运营系统，并秉持与直营店相同的标准，通过设备采购费、加盟费、培训费、运营费等为公司产生间接收益。加盟店的运营管理流程相对简化，能够为福寿康带来更快的扩展速度、更高的客户存量和更大的市场份额。

4.3.3. 长期战略：外延并购，业务多元化

福寿康需要积极拓展多元的商业化业务，减少整体经营对长护险等政策支持的依赖，可以借鉴 Amedisys 的**并购模式**，助力公司迅速扩展规模、扩张业务百度，保持优质服务，提高运营效率及盈利能力，并提升品牌效应。通过整合进安

宁疗护类或医护设备类公司,进一步开发临终关怀业务，为处在生命末期的人提供安慰和支持，提升病人及家庭成员的生活质量和尊严；通过并购目标地区的护理机构和社区服务站点，可以增加在当地的市场渗透率及客户基础，并巩固公司的领先地位；通过与国内各类医疗机构、保险公司以及地方社区组织建立战略合作关系,可以有效拓展业务覆盖率，进行垂直的服务管理，进一步完善老年护理的支付和服务流程，提供“一体化”的无缝衔接服务。

更进一步地，福寿康可以将并购目标聚焦在护理资源短缺的三四线城市，以较低成本进入市场，为潜在客户提供可负担的护理服务。同时，福寿康可以积极与社区或者相关公益组织合作，切实关注患者的社会和心理需求，增强其社区融入感，为患者构建多元化、全方位的服务体系。具体到操作层面，福寿康在部署战略性收购的过程中可以考虑以下六个判断标准：①目标品牌声望及客户网络；②收购目标与公司增长战略的一致性；③目标与公司现有门店实现协同效应的潜力；④目标潜在回报及预计未来价值；⑤收购目标目前的运营及能力，考虑其专业人员及设施、所需执照及经营许可；⑥将所收购业务整合至运营的预计成本、持续运营开支及资本需求。

4.3.4. 盈利实现：持续商业化

福寿康在支付体系上进行了创新，推出了**“长护险+商保+自费”**的组合支付体系。未来福寿康应该采取**以价值为基础**的支付模式，锚定服务质量，形成将护理服务和高级分析相结合的商业模式，以更好地为医疗保健需求日益复杂的个人提供持续性的管理和服务。此类模型旨在将传统的付款人模型从运营重点从为医疗保健和定价风险提供资金，转向更加集成的、高质量、成本效益高的管理式医疗模型，以更好地调整激励措施并提供更高质量、更好的体验、更低成本和更容易获得的护理。比如责任型护理组织（ACOs）、捆绑支付、按绩效支付等替代支付模型（APMs）正在被广泛采用，以促进医疗服务的有效利用和成本控制。根据麦肯锡的研究，在对支付方规模、地理足迹和细分市场组合进行标准化后，部署下一代管理式医疗模式的支付方产生的 EBITDA 利润率比平均预期高出 0.5 个百分点。

4.3.5. 目标达成：打通养老服务全链条

打通养老服务全链条：居家、社区、机构养老一体化。福寿康应积极打通与社会多方的联络，构建多层次、全方位的护理网络，通过共享老年人的健康信息、就诊记录、个性化需求等数据并搭建技术驱动的管理平台，确保老年人在不同的服务阶段和护理环境中能够得到及时、连贯的照护，实现无缝衔接、高效转介。全链条体系的协同对于公司是形成可持续商业模式的关键点，可以帮助公司具备应对未来政策调整、市场变化等带来的或有挑战与冲击，最终帮助企业形成以全方位个性化照护为核心、全面数字化和资源整合的**“一体化智慧养老服务生态”。**

5. 总结与展望

前文由宏观、中观至微观全面呈现了我国养老照护行业的发展图景，深入分析了中国老龄化的背景及银发经济发展的机遇与挑战，养老照护行业的市场现状、政策方向和运营模式，并结合中外企业发展模式，分析了代表企业福寿康的发展现状和未来优化战略。随着人口老龄化的加速，养老照护服务行业正迎来前所未有的发展机遇，也亟须我国加快部署，为不断增多的老龄人口提供更友好的生活环境。据此，我们对养老服务行业及代表企业福寿康做出如下发展展望。

5.1. 行业端：产业发展与政策保障协同，共同打造老年友好型社会

未来，我国养老服务行业将呈现以下发展趋势：

1）**居家社区养老为主。**未来居家养老模式或将成为主流趋势，社区养老和机构养老则成为重要的补充。从模式选择来看，于政府，居家养老社会负担小；于老年人，家庭环境熟悉、更加经济方便，居家养老有广泛的民意基础。同时，随着养老资源不断向居家社区养老服务倾斜，适老化改造、社区养老服务机构、家庭养老床位的普及将为居家养老模式奠定重要的设施基础，不断推动居家养老模式落地成熟。

2）医养结合。当前我国 60 岁以上老年人口有 2.53 亿以上，其中 1.8 亿以上的老年人患有慢性病，失去自理能力和半失去自理能力的老年人约 4200 万，许

多老年人面临着医疗服务难以全面覆盖日常生活的问题。医养结合模式将医疗资源与养老服务有机结合，为老年人提供全方位、持续性的医疗保健和生活照料服务，包括慢病预防、医养康养、老年康复等，是解决养老服务“最后一公里”的重要手段。但目前我国医养结合存在较大结构性失衡，多头监管、人才失衡、医保覆盖不足以及薄利经营等问题仍需进一步改善。

3）**需求多元化。**随着老年人口数量的增加，以及群体受教育程度、消费水平等人口特征的更新，中国特色养老概念的内涵——“养老即生活”受到更多老年人的推崇。其中所强调的“多层次养老需求都应该得到满足，而不仅是基本的生存照顾”理念引发市场关注。为老年群体提供包含居家照护、旅游、旅居、健康理疗、金融理财、遗嘱继承、法律咨询等丰富的服务，不断满足老年群体多元化的需求将是未来养老照护行业发展的着力点。

4）**养老科技化。**居家养老模式的深入发展将催生市场对智慧居家养老产品的大量需求，目前，照护机器人、脑机接口、人工智能等产品已逐步进入养老服务市场，为老年人视力、听力、记忆力、运动控制力等功能退化、缺损提供智能科技代偿，并辅助或代替人力照护。国家人口基础信息库、国家社会保险数据库、老年人健康数据库的共享复用，也为完善养老服务政策提供更丰富的科学依据。随着国家新质生产力建设的深化进行，数字化适老应用与服务将进一步铺开，为老年人提供更加安全、舒适、便利的数字化智慧化生活环境。

5）**服务体系化。**“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划提出了“构建和完善兜底性、普惠型、多样化的养老服务体系”的目标。目前，中国的养老服务体系包括居家、社区和机构养老照护服务等多种模式，为老年人提供了更多选择也推动了养老产业向体系化、专业化发展。从区域分布上看，目前养老产业在大城市相对发达，未来需要充分下沉，不断健全县（区）、乡镇（街道）、村（社区）的三级养老服务网络。同时，我国长护险等医疗保障体系也需要不断完善，如丰富筹资渠道、创新给付方式、拓宽保障范围、规范保障标准等。

5.2. 企业端：展望未来十年，助天下长者生活更美好

从 2011 到 2024 年，得益于长护险制度的不断试点和落地，福寿康从长三角出发，不断向外拓展业务规模，居家护理市场逐步走向平台期。“十四五”时期

是应对人口老龄化的重要窗口期，预计这一时期我国人口将进入中度老龄化阶段，2035 年前后进入重度老龄化阶段。宏观背景下，国家会加速推进长期护理保险制度的落地，未来十年仍是长期护理保险制度推动下的居家护理的重要窗口期。据此，我们对福寿康未来十年的发展规划作出如下展望：

5.2.1. 2024—2027 年：夯实基础，推动业务规模化

未来 2-3 年内，随着长护险试点的不断铺开，参保人员的进一步覆盖，福寿康应积极通过“直营”+“加盟”模式拓展在北部、西部的服务布局，加速在中部、东部地区三四线城市的市场下沉，扩大服务覆盖范围。同时，持续扩大自有护理培训中心和基地的覆盖范围，依托丰富的教学培训经验不断创新创造，持续优化培训体系，加快建设、壮大多层次、高素质的专业服务团队，提升服务质量。在现有的信息化平台基础上，借助投资人资源或引入信息管理平台供应商，充分利用大数据、人工智能等新兴技术优化平台模型，对内提高系统运作效率，对外提升系统易用性；在合规范围内，提前布局居家照护服务数据库建设，为后续发展做好储备。

5.2.2. 2028—2030 年：整合并购，赋能服务多元化

进入 2028 年，随着我国基本养老服务体系建设的不断深入，基本养老服务制度体系、服务清单、服务保障、服务监管将进一步完善，基本养老服务体系覆盖全体老年人。这一阶段，福寿康应致力于拓展业务内容并实现多元化发展，以适应养老服务市场的众多需求。福寿康应结合既往服务中的市场洞察，自主优化、开发一系列新的服务项目；或通过整合并购吸纳具有相似业务的护理机构和社区服务站点、具有相邻业务的地区性机构，快速增加业务种类，实现服务内容的扩散延伸，如推出临终关怀、家庭健康管理等增值服务，满足老年人更深层次的需求。同时，在业务多元化的基础上推动收入结构商业化转型，采取以价值为基础的支付模式，锚定服务质量，形成将护理服务和高级分析相结合的商业模式，更好地为老年群体提供持续性的管理和服务，也增强企业收入质量与盈利稳定性。

5.2.3. 2031—2035 年：打通养老服务全链条，实现一体化智慧养老

随着养老产业基础设施建设的不断完善，大数据、人工智能等科学技术的进一步成熟，福寿康应加大力度整合居家、社区和机构养老资源，打造综合性的护理网络；进一步整合养老服务产业链的上下游资源，形成从健康咨询、疾病预防、日常照护到专业康复的完整服务体系；加强与国内各类医疗机构、保险公司以及地方社区组织的战略合作，共同打造“全链条”“一体化”的养老服务模式。同时，结合前期居家照护服务数据库建设，深度融合人工智能、大数据等前沿技术，进一步推动服务的个性化和智能化，实现服务效率和质量的显著提升。此外，福寿康应积极开展品牌建设、市场营销和公共关系活动，增强品牌影响力，并作为养老服务行业的领导者，担负起为行业树立标准，为行业形成规范，为行业的创新和发展赋能助力的重任。

展望未来，我国养老服务行业将在政策指引和技术创新的推动下，在政府与企业的协同努力中释放活力、蓬勃发展，形成以老年人需求为基础的多元化、个性化服务体系，为老年人提供全方位、多层次的服务和产品。力争到 2035 年，全面建成覆盖全体老年人、权责清晰、保障适度、可持续的基本养老服务体系，助天下长者生活更美好。

参考文献

[1]《2023 年度国家老龄事业发展公报》，中华人民共和国民政部、全国老龄办，www.gov.cn/lianbo/bumen/202410/P020241012307602653540.pdf。

[2]任泽平：《中国老龄化研究报告 2022》，20229281791192316.pdf。

[3]Yanan Luo , Binbin Su , Xiaoying Zheng：《Trends and Challenges for Population and Health During Population Aging — China, 2015–2050》（中国人口老龄化时期人口与健康的趋势和挑战（2015—2020）），https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34594944/。

[4]《2023 年中国养老产业全景图谱》，前瞻产业研究院，https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/230720-eb37d7dd.html。

[5]《中国老龄化报告 2024》，泽平宏观，https://new.qq.com/rain/a/20240604A007EB00。

[6]《国务院关于推进养老服务体系建设、加强和改进失能老年人照护工作情况的报告》，中华人民共和国民政部，http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202409/t20240911_439362.html。

[7]《国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，国务院办公厅，https://www.gov.cn/zhengce/content/202401/content_6926087.htm。

[8]艾瑞咨询：《江涵秋影雁初飞-中国养老服务发展报告》，2021 年。

[9]艾瑞咨询：《中国商业养老服务市场发展研究报告》，2022 年。

[10]华西证券：《各国养老金体系研究综述》，2022 年 4 月。

[11]兴业证券：《全球公共养老基金研究系列之五:海外国家基本养老金深度对比》，2021 年 11 月。

[12]《全国企业年金基金业务数据摘要（2023）》，中华人民共和国人力资源和社会保障部。

[13]《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》，国务院办公厅。

[14]《关于养老、托育、家政等社区家庭服务业税费优惠政策的公告》，财政部。

[15]《重磅！2023 年中国及 31 省市养老产业政策汇总及解读》，前瞻产业研究院，https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/230630-20894f4e.html。

[16]《养老产业统计分类（2020）》，国家统计局，2020 年。

[17]《第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查》，中国老龄科学研究中心，2024 年 10 月。

[18]《2022 年养老消费调查项目研究报告》，中国消费者协会，2022 年 12 月。

[19]艾年：《九成老人居家养老，万亿蓝海如何破局？》，澎湃新闻，https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_26222974。

[20]《2023 年中国养老产业投融资现状及兼并重组分析 2022 年投融资金额呈现爆发式增长》，前瞻产业研究院，https://bg.qianzhan.com/trends/detail/506/230710-42e171b2.html。

[21]张梦琦：《中日长期护理保险制度比较与启示》，辽宁师范大学硕士论文，2022 年。

[22]张文娟，李念：《现金或服务：长期照护保险的给付制度分析》，载《中国卫生政策研究》，2020 年 2 月第 13 卷第 2 期。

[23]21 世纪经济报道：《中国居家养老发展趋势白皮书》。

[24]张昀：《日本长期护理保险制度及其借鉴研究》，吉林大学博士论文，2016 年。

[25]陈娜，王长青：《日本介护保险制度对健全我国失能老人照护体系的启示》，载《中国卫生事业管理》，2019 年。

[26]付思佳，张良文，阙霜，方亚：《长期护理保险经办管理模式及风险防控研究》，载《卫生经济研究》2022 年 1 月第 39 卷第 1 期。

[27]范蠡，徐卫东：《美德日个人养老金制度及其对中国的启示》，载《人口学刊》，2024 年第 45 期。

[28]福寿康官网，https://www.zhaohu365.com/。

[29]璞缘照护微信公众号，https://mp.weixin.qq.com/s/GzaFZo1OYomjm1myusDV1g。

[30]小橙长护官网，https://www.xiaochengch.com/jtjs。

[31]颐家养老官网，https://www.day-care.cn/。

[32]小橙集团微信公众号，https://mp.weixin.qq.com/s/5GM0U0ch4tvV02gOw_Jg_Q。

[33]《从事养老行业的前景如何？居家养老服务头部企业「福寿康」分析》，上海安颐养老服务有限公司，https://mp.weixin.qq.com/s/TjlENuNpfutCX80QsBN8YQ。

[34]王鑫雪：《前世界 500 强企业高管养老产业创业，璞缘照护 6 年落地 31 个城市》，动脉网，https://www.163.com/dy/article/IP1S80F905118K9D.html。

[35]《实战|小橙长护：获数千万元 Pre-A 轮融资/年营收 2 亿，如何抢跑长护险刚需市场？》，AgeClub，https://t.cj.sina.com.cn/articles/view/6859155568/198d6687001900z6yt。

[36]《年服务超千万人次，颐家如何用数智化技术破解居家养老盈利难困境？》，AgeClub，https://www.shangyexinzhi.com/article/17287386.html。

[37]《颐家发布居家医养创新模式，实现“品质规模化复制”》，36 氪，https://www.36kr.com/p/2243228360404610。

[38]段明杰：《深度：完成 B 轮数千万美元融资的「福寿康」，到底是一家怎样的养老企业》，知乎，https://zhuanlan.zhihu.com/p/342262972。

[39]刘旷：《银发经济硬战：福寿康稳步拓荒，小柏家护轻装上阵》，福布斯中国，https://www.forbeschina.com/innovation/61726。

[40]平安证券：《养老产业现状研究专题（三）：养老照护服务重在实现“居家社区机构相协调”》,2024 年 10 月。

[41]《福寿康“互联网+医养康护”服务，让长者生活更美好》，搜狐新闻，https://www.sohu.com/a/354472132_460199。

[42]《启明对话 CEO|福寿康：有温度的医养康复服务》，启明新闻。

[43]刘志华、董晋之：《人民网研究院调研报告：养老护理人才缺口大，怎么看、怎么办？》，人民网研究院，http://yjy.people.com.cn/n1/2024/0429/c244560-40226657.html。

[44]Amedisys 官网，https://www.amedisys.com/。

[45]Amedisys，维基百科，https://en.wikipedia.org/wiki/Amedisys。

[46]Focus Reports：《U.S. Elderly Care Services Market - Focused Insights 2024-2029》，https://www.focusreports.store/report/us-elderly-care-services-market-focused-insights。

[47]《估值 33 亿美元！Amedisys 如何发展成为美国「居家养老」服务巨头》，知乎，https://zhuanlan.zhihu.com/p/577102255。

[48]王璨：《产业观察|一个临终关怀产业的观察样本：市值 80 亿美元的 Amedisys 的扩张之路》，36 氪，https://www.36kr.com/p/953586255182216。

[49]《探针资本_上市公司分析：InnovAge Holding, Inc.》，搜狐新闻，https://www.sohu.com/a/517727990_121124378。

[50]Luciano Colos:《Amedisys Inc: Business Model, SWOT Analysis, and Competitors 2024》，https://pitchgrade.com/companies/amedisys-inc。

[51]《Amedisys Inc: Overview》，Global Data，https://www.globaldata.com/company-profile/amedisys-inc/。

[52]蔡伟贤，吕函枰，沈小源：《长期护理保险、居民照护选择与代际支持——基于长护险首批试点城市的政策评估》，载《经济学动态》，2021 年第 10 期

[53]李新平，何静然：《我国商业护理保险发展问题研究——与德国市场的比较分析》，载《中国保险》，2024 年 5 月

[54]太保安联：《中国商业长期护理保险发展模式和实践研究报告》

[55]海通国际：《首次覆盖：健康与美丽连锁服务龙头，打造一站式服务体系》

[56]《Alternative Payment Model Framework》，Health Care Payment Learning & Action

Network，https://hcp-lan.org/workproducts/apm-framework-refresh-draft.pdf

[57]程明梅，杨华磊：《中国城镇失能老年人口规模及养老服务需求预测》，载《北京社会科学》，2024 年第 3 期。

[58]CMF 中国宏观经济专题报告（第 84 期）：《我国银发产业高质量发展的机遇、挑战与策略选择》。

[59]平安证券：《银发经济系列报告（二）：把脉政策：从关键词看银发经济投资机会》，2024 年 5 月。

[60]沙利文：《2024 年中国银发经济发展报告》。

[61]艾媒咨询：《2024-2025 年中国银发经济投资前景分析报告》，https://www.iimedia.cn/c400/101206.html。

